



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG
Subsecretaria de Vigilância em Saúde

PLANO DE ENFRENTAMENTO AO EL NIÑO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Preparação, Monitoramento
e Resposta do Setor Saúde

**Belo Horizonte – MG
2026**



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG
Subsecretaria de Vigilância em Saúde

PLANO DE ENFRENTAMENTO AO EL NIÑO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Plano elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, com a finalidade de orientar as ações de preparação, monitoramento, resposta do setor saúde frente aos impactos decorrentes do fenômeno El Niño no território do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte – MG

2026

MATEUS SIMÕES DE ALMEIDA

Governador do Estado de Minas Gerais

FÁBIO BACCHERETTI VITOR

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

POLIANA CARDOSO LOPES

Secretária de Estado Adjunta de Saúde

EDUARDO CAMPOS PROSDOCIMI

Subsecretário de Vigilância em Saúde

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	6
2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO E CENÁRIOS DE RISCO	14
3. ESTRATÉGIA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA	24
4. ESTRUTURA, ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO COE	108
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	121
6. REFERÊNCIAS	122
7. ANEXOS	124

Lista de Quadros e Tabelas

QUADRO – Caracterização do território e histórico de eventos: riscos climáticos à saúde, áreas críticas, principais vulnerabilidades, impactos ao setor saúde e nível de prioridade.

Quadro 01 – Descrição dos estágios operacionais para o cenário de chuvas.

Quadro 02 – Descrição dos indicadores para o período chuvoso.

Quadro 03 – Descrição dos estágios operacionais para o cenário de seca e estiagem.

Quadro 04 – Descrição dos indicadores para o período de seca e estiagem.

Quadro 05 – Setores de atuação no estágio operacional de normalidade para o período chuvoso e suas ações.

Quadro 06 – Setores de atuação no estágio operacional de mobilização para o período chuvoso e suas ações.

Quadro 07 – Setores de atuação no estágio operacional de alerta para o período chuvoso e suas ações.

Quadro 08 – Setores de atuação no estágio operacional de emergência para o período chuvoso e suas ações.

Quadro 09 – Setores de atuação no estágio operacional de crise para o período chuvoso e suas ações.

Quadro 10 – Setores de atuação no estágio operacional de normalidade para seca e estiagem e suas ações.

Quadro 11 – Setores de atuação no estágio operacional de mobilização para seca e estiagem e suas ações.

Quadro 12 – Setores de atuação no estágio operacional de alerta para seca e estiagem e suas ações.

Quadro 13 – Setores de atuação no estágio operacional de situação de emergência para seca e estiagem e suas ações.

Quadro 14 – Setores de atuação no estágio operacional de crise para seca e estiagem e suas ações.

1. Introdução

O Plano de Enfrentamento ao El Niño de Minas Gerais foi elaborado de forma intersetorial pela Secretaria de Estado de Saúde, com a participação de diferentes áreas técnicas, visando fortalecer a prevenção, preparação e resposta às emergências em saúde pública relacionadas a seca e estiagem, chuvas intensas, incêndios florestais e outros impactos associados ao fenômeno El Niño. A iniciativa busca integrar conhecimentos e alinhar estratégias para reduzir os impactos do fenômeno El Niño sobre a população e os serviços de saúde.

Nesse contexto, este Plano de Enfrentamento tem como objetivo apresentar informações sobre a intensificação de condições climáticas adversas associadas à atuação do El Niño ao longo do segundo semestre de 2026, bem como níveis operacionais de resposta da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

Conforme observado historicamente, o El Niño pode provocar impactos marcantes nos padrões de precipitação e na temperatura do ar em grande parte do território brasileiro. De acordo com as previsões atuais, o fenômeno tem alta probabilidade (superior a 80%) de se configurar ao

longo do segundo semestre de 2026, podendo se estender até, pelo menos, o início de 2027.

Minas Gerais, em razão de sua extensa dimensão territorial, diversidade climática, heterogeneidade socioeconômica e expressivas diferenças regionais, apresenta múltiplas vulnerabilidades frente aos efeitos das mudanças climáticas. O estado registra, de forma recorrente, eventos hidrológicos extremos, períodos de estiagem e seca, elevação das temperaturas, incêndios florestais e outros fenômenos ambientais capazes de impactar a ocorrência de doenças e agravos, a segurança hídrica e alimentar, as condições de trabalho, a saúde mental da população e a capacidade de resposta dos serviços de saúde (Minas Gerais, 2025).

1.1. Governança e coordenação do plano

- Área responsável pela coordenação do plano;

A coordenação deste Plano é de responsabilidade da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, que atua na articulação das ações de vigilância, promovendo a integração entre as áreas técnicas da SES-MG e os órgãos parceiros envolvidos na gestão do risco, na preparação e na resposta aos eventos decorrentes do El Niño.

- Áreas participantes da elaboração;

O Plano de Enfrentamento ao El Niño para o estado de Minas Gerais é resultado de um processo contínuo de discussão e organização de estratégias para a contingência das emergências em saúde pública relacionadas aos fenômenos climáticos seca/estiagem, chuvas intensas, incêndios florestais e desastres associados, sendo uma construção intersetorial conduzida pela Secretaria de Estado de Saúde, com a participação de diferentes áreas técnicas. A articulação intra e intersetorial tem como objetivo integrar conhecimentos, alinhar competências e definir estratégias para a prevenção, preparação, resposta frente aos impactos do fenômeno El Niño sobre a saúde da população e os serviços de saúde.

Participaram da elaboração deste Plano, através de documentos existentes no Estado, consultados para essa construção, as seguintes subsecretarias da SES-MG: Subsecretaria de Vigilância em Saúde, Subsecretaria de Redes de Atenção à Saúde (SUBRAS), Subsecretaria de Acesso a Serviços de Saúde (SUBASS), Subsecretaria de Gestão e Finanças (SUBGF) e Subsecretaria de Regionalização (SUBR).

- Instituições parceiras (Defesa Civil, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Corpo de Bombeiros, universidades etc.);

O enfrentamento dos impactos decorrentes do fenômeno El Niño demanda atuação integrada entre diferentes órgãos e instituições, considerando a natureza multissetorial dos eventos extremos que afetam a saúde da população e unidades de saúde. Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais mantém articulação permanente com

instituições parceiras, como a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), órgãos de meio ambiente e de recursos hídricos, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instituições de ensino e pesquisa, entre outros atores estratégicos.

Como parte dessa articulação, a SES-MG integra o Comitê Gestor de Medidas de Prevenção e Enfrentamento das Consequências do Período Chuvoso, coordenado pela CEDEC, contribuindo para o planejamento, o monitoramento e a coordenação das ações interinstitucionais voltadas à redução dos impactos dos eventos climáticos relacionados às chuvas.

Além disso, a Secretaria conta com o apoio de uma Assessoria Militar, que fortalece a interlocução com os órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, com ênfase no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e apoia a coordenação de ações estratégicas em emergências e desastres. Entre essas ações, destaca-se o Serviço Aéreo de Suporte Avançado de Vida (SAAV), o programa aeromédico do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), desempenhando papel fundamental no atendimento e transporte aeromédico em situações de urgência, calamidades e desastres. Também conta com a cessão de uma militar para compor a equipe do Programa Vigidesastres, fortalecendo a capacidade técnica e operacional para o monitoramento, a preparação e a resposta às emergências e desastres com repercussão na saúde pública.

- Representante estadual

Eduardo Campos Prosdocimi

Subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

Tel: (31) 3916-0517

E-mail: subvs@saude.mg.gov.br

1.2. Contextualização

O El Niño é a fase quente do fenômeno El Niño–Oscilação Sul (ENOS), caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aquecimento modifica a circulação atmosférica global, alterando os padrões de temperatura, precipitação e transporte de umidade em diferentes regiões do planeta. No Brasil, seus efeitos variam conforme a região, sendo comum a ocorrência de chuvas acima da média na Região Sul e redução das precipitações em áreas do Norte e do Nordeste, além do aumento das temperaturas em grande parte do território nacional (INPE et al., 2026).

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), há previsão de que o El Niño interaja com o aquecimento global, podendo contribuir para que os anos de 2026 e 2027 sejam mais quentes se comparado ao período de 2023 e 2024, o que pode aumentar o risco de incêndios na Amazônia e no Pantanal. Esse cenário poderá ampliar a vulnerabilidade ambiental, com potencial aumento do risco de ocorrência de incêndios florestais nos biomas Amazônia e Pantanal, além de favorecer impactos à saúde da população decorrentes da exposição ao calor extremo, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No que se refere a possibilidade de desastres, não é possível antecipar a ocorrência de eventos específicos, mas há

probabilidade com tendência de aumento relativo dos riscos de desastres de origem hidrológica e geológica na região Sul associados ao excesso de chuvas e episódios de secas e alto risco de incêndios de vegetação nas regiões Norte e Nordeste (CEMADEN, 2026).

Além dos impactos climáticos, o El Niño pode influenciar diversos setores, especialmente a saúde pública, ao favorecer a ocorrência de eventos extremos, como enchentes, secas, queimadas e ondas de calor, que aumentam o risco de doenças transmitidas por vetores, doenças de veiculação hídrica e agravos respiratórios. No entanto, o fenômeno não deve ser interpretado como causa única desses eventos, pois seus efeitos dependem da interação com outros sistemas climáticos e das condições socioambientais de cada território. Dessa forma, o monitoramento contínuo e o planejamento preventivo são fundamentais para reduzir os impactos sobre a população e fortalecer a capacidade de resposta dos serviços públicos (FIOCRUZ, 2026).

1.3 Justificativa

A preparação do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais para o enfrentamento ao El Niño é de fundamental importância para melhor organizar as ações e as atividades a serem desenvolvidas no território. O planejamento prévio garante uma articulação eficiente entre os municípios e o Estado, em Nível Central e Regional, reconhecendo as diferenças e necessidades locais e regionais, como forma de garantir um apoio adequado e qualificar a gestão de riscos aos desastres em Minas Gerais.

1.4. Objetivos (geral e específico)

Objetivo Geral

Estabelecer diretrizes técnicas e operacionais para o planejamento, monitoramento, preparação, resposta e recuperação do setor saúde frente aos impactos decorrentes do fenômeno El Niño no estado de Minas Gerais, especialmente aqueles relacionados à ocorrência de chuvas intensas, inundações, enxurradas, alagamentos, movimentos de massa, estiagens, ondas de calor e outros eventos extremos, visando reduzir os riscos, os danos e os impactos à saúde da população, bem como assegurar a continuidade das ações e dos serviços do Sistema Único de Saúde.

Objetivos Específicos

1. Orientar o Estado e os municípios quanto ao planejamento e à organização das ações de vigilância, assistência e gestão em saúde diante dos impactos decorrentes do fenômeno El Niño;
2. Monitorar alertas climáticos, meteorológicos e hidrológicos por meio de plataformas e sistemas oficiais;
3. Fortalecer a articulação entre os níveis estadual e municipal para a gestão dos riscos e desastres associados aos eventos hidrometeorológicos relacionados ao El Niño;
4. Fortalecer a articulação entre os níveis estadual e municipal para o planejamento e a gestão dos riscos à saúde decorrentes da seca, da estiagem e das ondas de calor associadas ao fenômeno El Niño.
5. Subsidiar a adoção de medidas de prevenção, mitigação, preparação e resposta com base na análise de riscos e no monitoramento dos eventos meteorológicos e hidrológicos;

6. Estabelecer fluxos de comunicação, competências e responsabilidades para atuação oportuna nas fases de normalidade, mobilização, alerta, situação de emergência e crise;
7. Promover a integração intersetorial e a atuação coordenada entre as áreas técnicas do setor saúde, envolvidas no enfrentamento aos impactos do fenômeno El Niño;
8. Fortalecer a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, reduzindo a morbimortalidade e minimizando os impactos dos eventos extremos sobre a saúde da população.

2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO E CENÁRIOS DE RISCO

2.1 O fenômeno El Niño–Oscilação Sul

O fenômeno El Niño–Oscilação Sul consiste em um sistema oceânico-atmosférico acoplado que se desenvolve na região do oceano Pacífico equatorial e na atmosfera adjacente. Caracteriza-se por anomalias na temperatura da superfície do mar (TSM) e na circulação atmosférica, as quais influenciam a dinâmica climática em escala global, alterando os padrões de circulação atmosférica, o transporte de umidade e os regimes de temperatura do ar e precipitação em diferentes regiões do planeta (INPE et al., 2026; FIOCRUZ, 2026).

O El Niño representa a fase quente do ENOS, caracterizada pelo aquecimento anômalo das águas superficiais do oceano Pacífico equatorial em relação à média climatológica. Em contrapartida, a *La Niña* corresponde à fase fria do fenômeno, sendo associada ao resfriamento anômalo das águas superficiais dessa mesma região. Essas oscilações exercem influência significativa sobre o comportamento climático, podendo modificar os padrões de precipitação e temperatura em diversas partes do mundo, incluindo o território brasileiro (INPE et al., 2026; FIOCRUZ, 2026).

As principais ameaças para o Sudeste são: atraso da estação chuvosa, ondas de calor e ocorrência de chuvas intensas localizadas. Durante a primavera (setembro a dezembro), o El Niño pode favorecer condições mais secas em parte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, aumentando a probabilidade de veranicos, temperaturas acima da média e atraso do período chuvoso. Ao mesmo tempo, a interação com outros sistemas atmosféricos pode ocasionar episódios

de chuvas intensas em algumas áreas, exigindo monitoramento contínuo das condições meteorológicas e preparação para eventos extremos (Brasil, 2026).

2.2. Caracterização do território e histórico de eventos

QUADRO – Caracterização do território e histórico de eventos: riscos climáticos à saúde, áreas críticas, principais vulnerabilidades, impactos ao setor saúde e nível de prioridade.

Riscos climáticos à saúde				
Ameaça climática	Áreas críticas	Principais vulnerabilidades	Impactos ao setor saúde	Nível de prioridade
Tempestades (Chuvas intensas/granizo/tempestade de raios)	URS Teófilo Otoni	Áreas mais suscetíveis (por localização e relevo) a chuvas intensas e eventos relacionados; Áreas com drenagem insuficiente; Condições de habitação e saneamento inadequados; Impermeabilização do solo; Populações vulneráveis (idosos, crianças, mulheres, pessoas com deficiência, gestantes); População vulnerabilizada (trabalhadores que atuam ao ar livre, trabalhadores que atuam em desastres)	Aumento da morbimortalidade da população decorrentes de infecções por doenças de transmissão hídrica, causas externas (afogamentos, acidentes e quedas); Sobrecarga dos serviços de saúde devido ao aumento da demanda; Interrupção dos serviços devido a falha ou parada no atendimento por comprometimento da estrutura física da unidade.	Alta
	URS Juiz de Fora			
	URS Ubá			
	URS Ponte Nova			
	URS Manhuaçu			
	URS Leopoldina			
	URS Coronel Fabriciano			
	URS Governador Valadares			
	URS Belo Horizonte			
	URS Sete Lagoas			
	URS Divinópolis			
	URS Barbacena			

Inundações/Enxurradas/Alagamentos	URS Pouso Alegre URS Juiz de Fora URS Ubá	Áreas mais suscetíveis (por localização e relevo) a chuvas intensas e eventos relacionados; Áreas com drenagem insuficiente; Condições de habitação e saneamento inadequados; impermeabilização do solo; populações vulneráveis (idosos, crianças, mulheres, Pessoas com deficiência); população vulnerabilizada (trabalhadores agrícolas, da limpeza urbana/ catadores de materiais recicláveis, construção civil)	Óbitos, lesões, fraturas, infecções; aumento de doenças transmissíveis, como leptospirose, hepatite A, doenças diarreicas agudas (DDA), infecções respiratórias, enfermidades transmitidas por vetores e infecções cutâneas; intoxicação por substâncias químicas	Alta
Geológicos (movimentos de massa (deslizamento, corrida de massa) /erosão)	URS Juiz de Fora URS Varginha URS Belo Horizonte	Áreas com drenagem insuficiente; Condições de habitação e saneamento inadequados; populações vulneráveis (idosos, crianças, mulheres, pessoas com deficiência, gestantes)	Óbitos, lesões, fraturas, infecções, Desassistência devido ao comprometimento da estrutura física dos serviços de saúde.	Alta

Seca/estiagem	URS Montes Claros URS Pedra Azul URS Teófilo Otoni URS Januária URS Pirapora	Baixa disponibilidade hídrica; baixos índices pluviométricos, Condições de habitação e saneamento inadequados; Sistemas de abastecimento vulneráveis; populações vulneráveis (idosos, crianças, mulheres, Pessoas com deficiência e gestantes)	Doenças transmissíveis (diarreia); doenças causadas pela poluição do ar; doenças transmitidas por vetores (febre maculosa); impactos psicossociais e na saúde mental (depressão, suicídios); deslocamento e migrações populacionais; interrupção nos serviços de saúde; má nutrição (desnutrição, deficiências nutricionais, sobrepeso e obesidade); desassistência devido à falta de água para a limpeza e atendimento nos serviços de saúde.	Alta
Onda de calor	URS Juiz de Fora URS Itabira URS Leopoldina URS Belo Horizonte	Ilhas de calor urbanas; Trabalhadores externos; Baixa umidade; populações vulneráveis (idosos, crianças, mulheres, Pessoas com deficiência e gestantes); condição financeira insuficiente da população para	Agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas e problemas renais pré-existent; Queimaduras e ferimentos; Transmissão acrescida de doenças transmitidas pelos alimentos – DTA's, pela água, por vetores (como mosquitos,	Média

		obter medidas adaptativas ao calor; população vulnerabilizada (trabalhadores ao ar livre, como da construção civil e agropecuários; profissionais de segurança; trabalhadores da limpeza urbana, da construção civil)	carrapatos, pulgas) e zoonoses, agravada pela rápida degradação dos alimentos no tempo quente; Desidratação, sensação de exaustão, câibras, síncope e erupções na pele. Acidentes com animais peçonhentos; Acometimento dos trabalhadores da saúde em serviços superaquecidos sem estrutura adequada;	
Incêndio florestal (queimadas)	URS Divinópolis URS Uberlândia URS Uberaba	Populações vulneráveis (idosos, crianças, mulheres, Pessoas com deficiência e gestantes); baixa umidade relativa do ar; áreas de mata, Vegetação seca; população vulnerabilizada (bombeiros e brigadistas, trabalhadores do campo)	A exposição à fumaça proveniente da queima da biomassa dos incêndios florestais pode causar a curto prazo: Irritação dos olhos, nariz, pele, garganta, chiado, tosse e aperto no peito e dificuldades respiratórias. Rouquidão. Lacrimejamento. Asma. Bronquite. Dores de cabeça. Tosse seca. Cansaço. Dermatites; Desassistência devido ao comprometimento da estrutura física dos serviços de saúde.	Média

Onda de frio	URS Juiz de fora URS Varginha URS Pouso Alegre	População em situação de rua, populações vulneráveis (idosos, crianças, mulheres, Pessoas com deficiência e gestantes); populações vulnerabilizadas (trabalhadores informais em ambientes externos, trabalhadores da construção civil, agricultores)	Aumento de infecções respiratórias agudas (resfriados, gripes, pneumonias). Agravamento de doenças respiratórias crônicas, como asma e bronquite. Exacerbação de doenças cardiovasculares (hipertensão, infarto). Hipotermia, especialmente em populações vulneráveis (idosos, pessoas em situação de rua). Agravos dermatológicos (ressecamento, fissuras, dermatites). Dores musculares e articulares.	Média
--------------	--	--	--	-------

Fonte: Adapta-SUS MG, 2026.

O Observatório de Clima e Saúde registrou aumento importante de eventos extremos no país entre 2020 e 2023, com crescimento no número de pessoas doentes e afetadas por desastres, além de agravos como doenças diarreicas, leptospirose, doenças transmitidas por vetores, estresse pós-traumático, intoxicações, quedas, interrupção de tratamentos crônicos e agravamento cardiovascular por exposição à fumaça (FIOCRUZ, 2023).

A frequência e a intensidade de desastres, principalmente os de origem natural, têm aumentado, como impactos das emergências climáticas, resultando em fenômenos como enchentes, alagamentos, vendavais, granizo, tornados, desmoronamentos e deslizamentos, devido a severas instabilidades atmosféricas (Brasil, 2014; Reis, 2015 apud MINAS GERAIS, 2024). Embora essas mudanças sejam variadas e muitas vezes imprevisíveis, é possível estabelecer um histórico de recorrência que permite identificar os tipos mais frequentes, cenários de risco, regiões afetadas e os Estados e municípios mais impactados por esses eventos (Minas Gerais, 2024).

O período chuvoso pode favorecer a ocorrência de diversos agravos à saúde, impondo importantes desafios aos serviços de saúde e à população afetada. Esses eventos podem causar a contaminação de fontes de água por esgoto e outros resíduos, comprometendo a qualidade da água destinada ao consumo humano e contaminando alimentos, o que aumenta o risco de doenças de transmissão hídrica e alimentar, como hepatite A, hepatite E e doenças diarreicas agudas (DDAs) (Minas Gerais, 2024). Adicionalmente, a exposição da população à água e à lama contaminadas favorece a ocorrência de leptospirose, enquanto o acúmulo de água e a alteração das condições ambientais podem contribuir para o aumento de doenças transmitidas por vetores. As enchentes também provocam o deslocamento de animais peçonhentos, aumentando o risco de acidentes, especialmente por escorpiões, serpentes e aranhas, em

decorrência da inundação de seus abrigos naturais e da maior proximidade desses animais com áreas habitadas (Minas Gerais, 2024).

Os alagamentos e desabamentos podem culminar em interdição de residências e, conseqüentemente, levar ao desalojamento ou desabrigamento da população. Os desabrigados irão para abrigos improvisados, o que aumenta a vulnerabilidade sanitária, considerando a perda de medicamentos de uso contínuo, que, por sua vez, provoca interrupção de tratamentos. Ainda, há maior risco de transmissão de doenças, aumento da violência entre os abrigados e intensificação de problemas relacionados a saúde mental, como o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

Já os períodos de seca e estiagem contribuem para a redução da umidade relativa do ar, elevação das temperaturas e aumento da concentração de material particulado, como poeira, no ambiente (Freitas et al., 2021). Nessas condições, a vegetação sofre desidratação progressiva, podendo atingir níveis críticos, o que favorece a ocorrência de incêndios florestais e a conseqüente deterioração da qualidade do ar (CBMMG, 2022). Esses fatores exercem impactos diretos sobre a saúde da população, elevando a ocorrência de agravos, especialmente doenças respiratórias e cardiovasculares, com maior intensidade entre grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e gestantes.

Os incêndios florestais têm se tornado mais evidentes em razão das mudanças climáticas, que contribuem para o aumento das temperaturas e a prolongação dos períodos de estiagem. Esse cenário favorece a

redução da umidade do solo e da vegetação, elevando a vulnerabilidade da cobertura vegetal à ignição e à rápida disseminação do fogo (Brasil, 2026) (Minas Gerais, 2024).

Adicionalmente, os impactos do calor extremo sobre a saúde humana variam desde manifestações clínicas leves, como desidratação, fadiga e cefaleia, até agravos graves, incluindo exaustão térmica, insolação e o agravamento de doenças cardiovasculares, respiratórias e renais (Rio de Janeiro, 2024; Brasil, 2026). Além dos efeitos fisiológicos diretos, episódios de calor extremo podem comprometer a segurança hídrica e alimentar, intensificar vulnerabilidades socioeconômicas e desencadear repercussões sobre a saúde mental da população. Esses impactos são mais pronunciados entre grupos populacionais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores expostos ao calor e indivíduos que vivem em condições precárias de moradia ou com acesso limitado aos serviços de saúde (Rio de Janeiro, 2024).

O calor elevado pode ocasionar uma variedade de síndromes clínicas resultantes da interrupção da termorregulação em pessoas expostas. Essas síndromes variam desde uma gravidade leve como edema pelo calor, até gravidade alta no caso de insolação, com a presença de uma disfunção termorreguladora grave. O estresse por calor pode produzir de sintomas leves a severos, levando inclusive ao coma e morte. Já os sintomas leves incluem edema, câibras musculares associadas à atividade física (principalmente ao ar livre), e rash por calor. Os sintomas moderados incluem: colapso ou desmaio relacionado à atividade física (síncope por

calor) e estresse por calor (ou exaustão por calor). E como sintoma grave a insolação, sendo exposta à extremos de temperatura. Além disso, a desidratação pode fazer parte do quadro, apesar de não caracterizar uma doença (Brasil, 2026).

As situações citadas podem incorrer, ainda, em sobrecarga dos serviços de saúde ou mesmo desassistência, que podem ocorrer por: interrupção de serviços de infraestrutura (falta de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento); perda de medicamentos e insumos; dificuldade de acesso da população e/ou profissionais de saúde aos estabelecimentos por danos às vias, interrupções de rotas e limitações de transporte; afastamento de profissionais por questões relacionadas ao trabalho (fadiga, estresse, exaustão física e emocional, adoecimento relativo ao trabalho, absenteísmo e redução da capacidade operacional das equipes); ou ainda por aumento da procura pelos serviços de saúde. Neste cenário, também é necessário apoio integrado dos entes federados para a busca de soluções a favor das populações afetadas.

3. ESTRATÉGIA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano para Enfrentamento ao El Niño é dividido em 6 estágios operacionais para o período de seca e estiagem e para o período chuvoso:

Fase de Normalidade – COR VERDE,

Fase de Mobilização – COR AMARELA,

Fase de Alerta – COR LARANJA,

Fase de Situação de Emergência – COR VERMELHA e

Fase de Crise – COR ROXA.

Cada estágio é definido por cenário, indicadores, ações e setores responsáveis, facilitando a coordenação e as tomadas de decisão

Cenário – Período Chuvoso

Quadro 01: Descrição dos estágios operacionais para o cenário de chuvas. Minas Gerais, 2026/2027

	Normalidade	Mobilização	Alerta	Situação de emergência	Crise
Cenário	Ocorrência de chuvas, podendo acontecer eventos de baixa magnitude e impacto nos serviços essenciais (saúde, abastecimento de água e energia). Ou Elevação do nível de água de bacias hidrográficas próximas (municípios ou estados vizinhos), mas sem risco ou ameaça.	Ocorrência de chuvas com registro de eventos de inundação/alagamento/enxurrada/movimento de massa com registro de danos humanos ou impacto direto nos serviços essenciais (saúde, abastecimento de água e energia), mas sem sobrecarga nos serviços de saúde Ou Elevação do nível de água de bacias hidrográficas próximas, atingindo a cota de atenção, em função do acumulado de chuvas.	Ocorrência de chuvas intensas com registro de eventos e danos humanos e impactos diretos nos serviços essenciais (saúde, abastecimento de água e energia), indicando possível sobrecarga nos serviços de saúde instalados, podendo exceder a capacidade de resposta dos municípios e/ou Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena) Ou Chuvas intensas com possibilidade de extrapolação da cota de inundação do rio.	Ocorrência de chuvas intensas com registro de eventos de desastres em municípios com desabrigados, desalojados, feridos, óbitos e comprometimento grave de serviços essenciais (saúde, abastecimento de água e energia). Ou Ocorrência de inundação excedendo a capacidade de resposta dos municípios e/ou Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena) e sobrecarregando os serviços estaduais.	Ocorrência de chuvas intensas com registro de inundação/alagamento em municípios, com grande número de desabrigados, desalojados, feridos, óbitos e unidades de saúde afetadas. Pode ser necessária a declaração de uma Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) para coordenar os esforços de resposta e garantir a alocação adequada de recursos. Ou Agravamento das condições de resposta do âmbito federal, gerando colapso do sistema de saúde.
Ativação da sala de situação ou COE	Comitê de Monitoramento de Evento (CME) rotineiro	CME semanal	Sala de Situação	Ativação COE	Ativação COE

Cenário – Período de Seca e Estiagem

Quadro 02: Descrição dos estágios operacionais para o cenário de seca e estiagem. Minas Gerais, 2026/2027

	Normalidade	Mobilização	Alerta	Situação de emergência	Crise
Cenário	Não se observam evidências de repercussões relevantes da seca ou estiagem sobre a saúde pública. Os sistemas de abastecimento de água operam dentro da normalidade, sem demanda por intervenções emergenciais. O acompanhamento das condições ambientais, climáticas e hidrológicas é realizado de maneira contínua, mantendo-se os indicadores dentro dos parâmetros históricos considerados regulares (Brasil, 2026).	Ocorrência de indícios de escassez hídrica, como redução dos níveis de chuva ou alerta de estiagem com duração prevista superior a 30 dias. Ainda não se observa o comprometimento grave do abastecimento de água para consumo humano (Brasil, 2026).	Agravamento das condições hidrológicas e sanitárias, sendo caracterizado por registros de precariedade no abastecimento de água para consumo humano, elevação da demanda por suporte logístico e surgimento dos primeiros impactos sobre a saúde pública (Brasil, 2026).	Ocorrência de comprometimento amplo dos sistemas de abastecimento, com repercussões diretas na saúde pública, elevação da ocorrência de surtos de doenças e necessidade de resposta coordenada em nível estadual. Verifica-se o colapso do abastecimento de água para consumo humano, tanto em áreas urbanas quanto rurais, associado ao aumento da incidência de doenças transmissíveis e outros agravos, como doenças diarreicas agudas (DDA), hepatites A e E e cólera, além de impactos evidenciados em indicadores de mortalidade. Registra-se, ainda, a interrupção do fornecimento de água em unidades de saúde e instituições de ensino (Brasil, 2026).	Ocorrência de comprometimento generalizado dos sistemas de abastecimento, com impactos diretos sobre a saúde pública, aumento da ocorrência de surtos de doenças e necessidade de resposta coordenada em nível estadual. Observa-se o colapso do fornecimento de água para consumo humano, tanto em áreas urbanas quanto rurais, associado à elevação da incidência de doenças transmissíveis e outros agravos, como doenças diarreicas agudas (DDA), hepatites A e E e cólera, além de reflexos nos indicadores de mortalidade. Constatam-se, ainda, interrupções no abastecimento de água em unidades de saúde e instituições de ensino (Brasil, 2026).
Ativação do COE	Não se aplica	Não se aplica	Avaliar necessidade de ativação	Ativação necessária	Ativação necessária

Indicadores – Período Chuvoso

Quadro 03: Descrição dos indicadores para o período de seca e estiagem. Minas Gerais, 2026/2027

	Normalidade	Mobilização	Alerta	Situação de emergência	Crise
Indicadores	Ausência de decretos de situação de emergência disponíveis no Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil nos últimos 10 dias.	Um alerta de “tempo severo” emitido pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE), ou alerta de nível “Alto” ou “Muito Alto” do CEMADEN.	Um decreto de situação de emergência disponível no Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil;	30 ou mais municípios com decretos de situação de emergência disponíveis no Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil nos últimos 10 dias ou 3 Unidades Regionais de Saúde comprometidas simultaneamente e acionando o Nível Central	Unidades de saúde de uma região atingida com registro de danos estruturais e com serviços interrompidos, sem possibilidade de reorganização imediata.
	E/ou Ausência de alertas de nível “Alto” ou “Muito Alto” emitidos pelo CEMADEN, ou ausência de alertas de nível “Perigo” e “Grande Perigo” emitidos pelo INMET.	E/ou o prognóstico de chuvas previstas nos últimos 10 dias pelo INMET.	E/ou Três ou mais rumores de mídia confirmados pelo CIEVS sobre a ocorrência localizada de alagamentos ou surtos nos últimos 10 dias.	E/ou Danos materiais e estruturais nos serviços essenciais (saúde, abastecimento de água e energia)	E/ou Ocupação dos leitos hospitalares superior a 90% devido a ferimentos e doenças relacionadas ao desastre (como leptospirose, diarreias ou traumas).
	E/ou Ausência de rumores sobre desastres com danos humanos ou serviços essenciais.	E/ou Uma ou mais bacias hidrográficas com níveis de atenção	E/ou Danos materiais e estruturais nos serviços essenciais (saúde, abastecimento de água e energia). E/ou Uma ou mais alterações do nível de alertas “Alto” para “Muito Alto” vigentes emitidos pelo CEMADEN E/ou	E/ou Aumento significativo de casos de doenças e agravos relacionados ao período chuvoso E/ou 1% da população residente do município desabrigada ou desalojada; E/ou Interrupção de vias rodoviárias estratégicas nacionais	E/ou Colapso na gestão de recursos e insumos de saúde; E/ou Inoperância parcial ou total dos sistemas de saúde de baixa, média e alta complexidade; E/ou Colapso do sistema de saúde por falta de recursos para manejo da emergência.

			Uma ou mais alterações do nível de alertas “Perigo” para “Grande Perigo” emitidos pelo INMET. E/ou Prognóstico meteorológico do Inmet indicando piora através de Previsão de chuvas intensas (>100 mm/24h), rajadas de vento superiores a 60 km/h, e possibilidade de alagamentos ou enxurradas; E/ou Uma ou mais bacias hidrográficas com níveis de alerta. E/ou Presença de notificação no Formulário de Notificação de Emergências/Catástrofes em Saúde Pública.	ou estaduais por mais de 48 horas; E/ou Interrupção de sistemas de energia elétrica ou telecomunicações por três ou mais dias em áreas afetadas; E/ou Uma ou mais bacias hidrográficas com níveis de inundação; E/ou Presença de 5 notificações no Formulário de Notificação de Emergências/Catástrofes em Saúde Pública.	E/ou Presença de 10 notificações no Formulário de Notificação de Emergências/Catástrofes em Saúde Pública.
--	--	--	---	--	--

Indicadores – Período de Seca e Estiagem

Quadro 04: Descrição dos indicadores para o período de seca e estiagem. Minas Gerais, 2026/2027

Indicadores	Normalidade	Mobilização	Alerta	Situação de emergência	Crise
	Publicação de alertas meteorológicos e prognóstico climático indicando regularidade das chuvas : INMET- (https://portal.inmet.gov.br/) ou INPE – (https://www.cptec.inpe.br/) ou Monitor de Secas - https://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=11&ano=2025). E/OU Ausência de notificações do Formulário de Notificação de Emergências/Catástrofes em Saúde Pública, e ausência (0) decretos de situação de emergência disponíveis no Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil Defesa Civil nos últimos 10 dias.	Prognóstico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indicando estiagem por mais de 30 dias. E/OU Um (1) alerta de identificação de risco iminente de seca e estiagem por meio de alertas identificados no Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE - https://simge.meioambiente.mg.gov.br/aviso-meteorologicos) e/ou Centro Nacional de Alertas Monitoramento e/ou de Desastres Naturais https://www.gov.br/cemaden/pt-br/assuntos/monitoramento/impactos-(CEMADEN-seca/monitoramento-de-seca-	Dez ou mais notificações de ocorrências relacionadas a seca e estiagem notificadas no Formulário de Notificação de Emergências/Catástrofes em Saúde Pública. E/OU Dez ou mais decretos de situação de emergência disponível no Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil. E/OU Cinco ou mais rumores de mídia confirmados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS sobre a ocorrência localizada de aumento de doenças de veiculação hídrica nos últimos dez dias.	20% de municípios com decretos de situação de emergência disponíveis no Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil e/ou Formulário de Notificação de Emergências/Catástrofes em Saúde Pública nos últimos dez dias ou três Unidades Regionais de Saúde comprometidas simultaneamente e acionando o Nível Central. E/OU Três ou mais rumores de mídia confirmados pelo CIEVS sobre a ocorrência localizada de surtos de doenças de veiculação hídrica (DDA, hepatites A e E, cólera) nos últimos dez	40% ou mais de municípios decretando situação de emergência pela Defesa Civil e Formulário de Notificação de Emergências/Catástrofes em Saúde Pública nos últimos dez dias e/ou quatro ou mais Unidades Regionais de Saúde comprometidas; E/OU Inoperância parcial ou total dos sistemas de saúde de baixa, média e alta complexidade (Brasil, 2025). E/OU Interrupção de

	Defesa Civil Defesa Civil nos últimos 10 dias.	para-o-brasil) e/ou o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET- https://portal.inmet.gov.br/). E/OU Redução de aproximadamente 30% da média de precipitação em dois trimestres (https://portal.inmet.gov.br/). Notificações de precariedade no abastecimento de água para consumo humano em comunidades isoladas. E/OU Aumento de 10% na identificação de focos de calor em relação ao mês anterior pelo Programa BDqueimadas-INPE (https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/). E/OU Uma a nove notificações do Formulário de Notificação de Emergências/Catástrofes em Saúde Pública, um a nove decretos de situação de emergência disponíveis no Boletim Estadual de Proteção e Defesa Civil Defesa Civil nos últimos 10 dias.	E/OU Boletins de estiagem crítica emitidos (INMET - https://portal.inmet.gov.br/ ANA/Monitor de Secas -- https://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=11&ano=2025). E/OU Aumento de 25% na identificação de focos de calor em relação ao estágio anterior pelo Programa BDqueimadas - INPE (https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/)	dias, assim como notificações de colapso do sistema de abastecimento em áreas urbanas ou rurais, e falta d'água em unidades de saúde ou escolas. E/OU Boletins de estiagem crítica emitidos (INMET - https://portal.inmet.gov.br/ ANA/Monitor de Secas -- https://monitordesecas.ana.gov.br/mapa?mes=11&ano=2025). E/OU Aumento de 50% na identificação de focos de calor em relação ao estágio anterior pelo Programa BDqueimadas - INPE (https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/).	serviços públicos essenciais (saúde, educação, transporte). Solicitação formal de apoio federal pelas Unidades Regionais de Saúde, apontando o esgotamento dos recursos municipais e estaduais. E/OU Agravo simultâneo de indicadores ambientais, sanitários e sociais, com aumento de 50% em relação ao estágio anterior na identificação de focos de calor pelo Programa BDqueimadas - INPE.
--	--	---	--	---	---

Ações - Período Chuvoso

Estágio operacional de NORMALIDADE

QUADRO 05: Setores de atuação no estágio operacional de normalidade e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1. Definir profissional para atuar como ponto focal nas ações de preparação e monitoramento relacionadas ao período chuvoso, tanto em nível central quanto regional. 2. Instituir e implementar o Projeto de Saúde no Território (PST), com foco no planejamento local, dimensionamento e otimização de recursos assistenciais de cada Unidade Básica de Saúde (UBS) com base em diagnósticos territoriais ascendentes e participativos. 3. Orientar os municípios quanto ao planejamento e à execução de estratégias de mitigação, monitorando as ações de preparação assistencial da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio de painéis estruturado e indicadores de cobertura da APS. 4. Fomentar a territorialização e o monitoramento sistemático de áreas e microáreas da APS por meio de geoprocessamento para identificar bacias de drenagem, áreas de alagamento, declividade acentuada de encostas, áreas suscetíveis a movimentos de massa e bolsões de vulnerabilidade socioambiental. 5. Mapear as áreas de cobertura das equipes de Saúde da Família (eSF) e os vazios assistenciais em locais propensos a isolamento por enchentes, cruzando mapas estruturais com dados gerados a partir do e-SUS Território e do Sistema de Informação para Atenção Primária à Saúde (SIAPS). 6. Identificar e monitorar comunidades tradicionais, populações do campo, da floresta, das águas, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, povos originários e outros envolvidos em políticas de equidades, mapeando suas áreas de risco e traçando rotas de contingência e evacuação adaptadas às tipologias locais e barreiras geográficas. 7. Verificar e monitorar a integridade estrutural e funcional física das instalações das UBS, revisando o estoque local de medicamentos, soros e vacinas, bem como de insumos odontológicos, assegurando a continuidade do atendimento e a resolutividade das equipes de saúde bucal, em articulação contínua com as Unidades Regionais de Saúde (URS). 8. Mapear e atualizar junto às URS a relação das salas de vacinação localizadas em áreas com histórico de enchentes, enxurradas, deslizamentos ou risco de isolamento geográfico, adotando medidas preventivas estruturais.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	9. Planejar, junto às URS, estratégias alternativas para a manutenção da vacinação de rotina conforme as normas do Programa Nacional de Imunização (PNI) em áreas de difícil acesso, incluindo a definição de locais de armazenamento temporário e rotas alternativas para a distribuição segura de imunobiológicos. 10. Manter atualizados no prontuário eletrônico (PEC) os cadastros domiciliares e individuais, orientando e qualificando as equipes para estratificar as famílias vulneráveis nas áreas de risco por meio da Escala de Risco Familiar de Coelho-Savassi integrada ao e-SUS APS. 11. Mapear e rastrear os usuários sob maior risco de vulnerabilidade clínica e social, incluindo idosos isolados, crianças menores de 5 anos, gestantes de alto risco, puérperas, recém-nascidos, portadores de patologias crônicas, pessoas com deficiência com limitação de mobilidade, acamados, usuários em oxigenoterapia domiciliar ou dependentes de equipamentos elétricos essenciais e medicamentos de uso contínuo. 12. Planejar e implementar a integração das ações de campo e dos mapas de atuação territorial entre os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), otimizando as rotas de visitas domiciliares e o monitoramento compartilhado dos microterritórios. 13. Elaborar, com o apoio das URS, cronogramas de educação permanente sobre gestão de riscos de desastres na APS, realizando a atualização de canais de comunicação interna e fluxos de acionamento emergencial dos profissionais. 14. Qualificar as equipes de APS para o manejo clínico, diagnóstico diferencial e identificação precoce de agravos relacionados a alagamentos, inundações e doenças de veiculação hídrica recorrentes no período sazonal. 15. Fomentar os fluxos de triagem e acolhimento nas UBS para oportunizar o atendimento de sintomas infecciosos e gastrointestinais agravados por eventos climáticos extremos. 16. Atualizar, publicar e divulgar protocolos, notas técnicas e orientações operacionais emitidos pelos órgãos oficiais (níveis central e regional) direcionados à prevenção, ao manejo de agravos e à organização do processo de trabalho das equipes municipais. 17. Estabelecer fluxos e definir critérios para a emissão de comunicados técnicos

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	aos profissionais da rede sobre a ocorrência de possíveis riscos e surtos de doenças de veiculação hídrica. 18. Elaborar e atualizar material técnico e educativo de comunicação de risco junto às URS, focando em medidas de prevenção e na gestão de riscos direcionada à população em geral. 19. Fomentar ações territoriais de educação em saúde integradas às rotinas assistenciais da APS, ativando redes de lideranças comunitárias e conselhos de saúde para o mapeamento colaborativo de riscos socioambientais e pactuação de ações preventivas. 20. Implementar oficinas de qualificação com atores comunitários e lideranças locais, promovendo medidas de autoproteção, preparação para contingências e atualização do calendário vacinal. 21. Integrar as ações de educação em saúde ao Programa Saúde na Escola (PSE), abordando de forma transversal temas relacionados a mudanças climáticas, riscos socioambientais e prevenção de doenças sazonais. 22. Prestar apoio institucional às referências de APS das URS para a organização, planejamento, qualificação técnica e implementação local dos Planos de Ação das UBS focados em preparação, cuidado e resposta ao período chuvoso.
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1. Realizar alinhamento prévio para definição de fluxos e critérios para eventual transporte aéreo de equipes e materiais em situações de desastre relacionados ao Período Chuvoso; 2. Promover capacitação periódica de profissionais e gestores para assistência em urgência e emergência em situações de desastres relacionados ao período chuvoso; 3. Estabelecer fluxo de comunicação com a gestão regional do SAMU 192 para definição prévia de estratégias operacionais em caso de necessidade; 4. Fazer o levantamento das bases do SAMU 192 mais próximas do território para prestar atendimento pré-hospitalar imediato ou posterior (número de base de suporte básico (USB) e de suporte avançado (USA) da região); 5. Definir previamente critérios e fluxos para acionamento do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV) em situações de desastre.

SETOR	AÇÕES
SAÚDE MENTAL	1. Divulgar a Nota Técnica nº 3/SES/SUBRAS-SAE-DPE-CESMAD/2024 sobre Orientações sobre cuidado em saúde mental em situação de emergências e desastres para os municípios atingidos pela chuva (2023 - 2024) como instrumento orientador para organização da atenção em saúde mental em situações de emergências e desastres; 2. Divulgar e orientar quanto à utilização do formulário de Atendimento em Saúde Mental em Evento de Urgência, como instrumento padronizado para registro e monitoramento em situações emergenciais; 3. Realizar diagnóstico situacional da Rede de Atenção Psicossocial, identificando lacunas assistenciais e necessidades de estruturação, incluindo composição mínima de equipe para atendimento em situações de crise; 4. Elaborar e atualizar material informativo contendo fluxos e pontos de atenção da rede de saúde mental para ampla divulgação; 5. Estruturar e alinhar estratégias de prevenção, preparação e organização do cuidado em saúde mental junto às coordenações municipais.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1. Manter atualizada a comissão de situações de calamidades em saúde da Superintendência de Assistência Farmacêutica, para atuar nas ações de preparação e monitoramento relacionadas ao período chuvoso (nível central e regional). 2. Manter atualizado e devidamente divulgada a Nota Técnica que traz orientações aos municípios atingidos por desastres no que se refere às ações de Assistência Farmacêutica.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	1. Atualizar e disponibilizar protocolos relacionados aos agravos prioritários do período chuvoso (leptospirose, hepatites A e E, arboviroses, manejo de animais peçonhentos, gastroenterites, dentre outras), bem como orientar quanto à utilização adequada dos sistemas de notificação e monitoramento.; 2. Divulgar protocolo e orientações técnicas aos profissionais de saúde para abordagem em eventuais situações relacionadas ao período chuvoso. (enchentes, inundações, etc.) no Estado de Minas Gerais; 3. Estabelecer doenças e agravos de interesse para intensificação do monitoramento oportuno e organização da vigilância ativa, conforme cenário epidemiológico; 4. Verificar a capacidade de suporte laboratorial e planejar estratégias de apoio técnico e provisão de insumos, quando necessário; 5. Estabelecer previamente diretrizes para estratégia vacinal em eventual cenário de alagamento ou inundação; 6. Verificar se as unidades de saúde onde estão armazenadas as vacinas e medicamentos estão funcionando de forma a garantir a preservação dos insumos (queda de energia, alagamento, destruição, dentre outros) avaliando riscos relacionados à queda de energia, alagamento ou outros danos estruturais; 7. Divulgar a Nota Técnica nº 122/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS que revogou as orientações a respeito da vacinação contra hepatite A na população afetada por inundações; 8. Divulgar às Secretarias Municipais de Saúde (SMS) material educativo (cartilhas, folders e spot de rádio) para reprodução local e utilização em eventual situação de emergência associada a inundações; 9. Divulgar e capacitar previamente os serviços de saúde quanto às orientações técnicas para manejo de abrigos em situações de desastres associados a inundações do documento técnico intitulado "Orientações aos serviços de Vigilância Sanitária das Unidades Regionais de Saúde e dos Municípios sobre o manejo de abrigos nos municípios atingidos por Desastres associados à Inundações"; 10. Monitorar casos e óbitos por Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Grave (SRAG) no território Estadual;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	11. Promover estratégias de capacitação para os profissionais de saúde. 12. Monitorar continuamente as coberturas vacinais, identificando municípios e grupos populacionais com baixas coberturas para implementação de estratégias de intensificação. 13. Elaborar e atualizar o plano de contingência da Rede de Frio para interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e outros eventos relacionados ao período chuvoso. 14. Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da Rede de Frio (câmaras refrigeradas, refrigeradores, geradores, nobreaks e caixas térmicas). 15. Monitorar diariamente as temperaturas dos equipamentos de conservação de imunobiológicos e manter os registros atualizados. 16. Verificar periodicamente a disponibilidade de insumos estratégicos, como imunobiológicos, seringas, agulhas, caixas térmicas, bobinas reutilizáveis, termômetros e equipamentos de monitoramento de temperatura. 17. Orientar os municípios quanto aos procedimentos para conservação, armazenamento e transporte de imunobiológicos em situações de emergência. 18. Capacitar continuamente os profissionais da Rede de Frio e das salas de vacinação sobre os protocolos de contingência e manejo de excursões de temperatura. 20. Manter atualizados os contatos das equipes estaduais, regionais e municipais responsáveis pela Rede de Frio e imunização.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1. Acompanhar e divulgar para as Unidades Regionais de Saúde as informações do Boletim da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil; 2. Acompanhar e divulgar para as Unidades Regionais de Saúde a Lista de Municípios com Decretos vigentes associados a desastres; 3. Realizar monitoramento sistemático de informações e rumores veiculados na mídia sobre ocorrência de chuvas intensas; 4. Monitorar alertas emitidos pelo Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE) e o prognóstico de chuvas; 5. Encaminhar alertas para as Unidades Regionais de Saúde (SES) que possuem municípios com risco de inundação para subsidiar medidas preventivas; 6. Planejar estoque estratégico e logística de distribuição de hipoclorito de sódio a 2,5% para eventual utilização para desinfecção caseira da água para consumo humano; 7. Promover capacitação em investigação de surto por doenças de veiculação hídrica e alimentar e orientar sobre a elaboração do plano de amostragem da vigilância da qualidade da água para consumo humano em situações de emergências em saúde pública; 8. Divulgar material educativo, antes da ocorrência de eventos, sobre os cuidados com a água para consumo humano, uso de hipoclorito de sódio para tratamento de água, lavagem e desinfecção dos reservatórios de água (cisterna, caixa d'água); 9. Participar do planejamento de ações preventivas voltadas à bacia hidrográfica e aos mananciais de abastecimento público das áreas com potencial risco; 10. Através da Sala de Situação, propor indicadores para monitoramento da situação dos desastres e seus desdobramentos.
SETOR	AÇÕES
SAÚDE DO TRABALHADOR	1. Elaborar e divulgar orientações técnicas às Unidades Regionais de Saúde e municípios sobre os impactos dos eventos climáticos extremos nas doenças e agravos relacionados ao trabalho. 2. Monitorar municípios historicamente afetados por enchentes, inundações e deslizamentos quanto aos impactos sobre populações em situação de maior

SETOR	AÇÕES
SAÚDE DO TRABALHADOR	vulnerabilidade para agravamento de doenças e agravos relacionados ao trabalho. 3. Planejar, conjuntamente com as demais áreas da vigilância em saúde, ações voltadas para a proteção da saúde dos trabalhadores envolvidos: nas atividades produtivas e da população exposta aos impactos ambientais e sociais decorrentes deles.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS	1. Elaborar e divulgar orientações técnicas às Unidades Regionais de Saúde e municípios sobre os impactos dos eventos climáticos extremos nos agravos e condições acompanhados pela DVCC; 2. Monitorar indicadores relacionados à tuberculose, hanseníase, HIV, hepatites virais, outras IST, violências e doenças e agravos não transmissíveis em municípios historicamente vulneráveis a desastres associados ao período chuvoso; 3. Orientar os municípios quanto à elaboração de estratégias para manutenção do tratamento e acompanhamento das pessoas com condições que demandam cuidado contínuo; 4. Divulgar orientações para prevenção da hepatite A e outros agravos relacionados à contaminação da água e dos alimentos em períodos de chuvas intensas e inundações; 5. Orientar os municípios quanto à vigilância e prevenção das violências em contextos de vulnerabilidade social e deslocamento populacional; 6. Monitorar municípios historicamente afetados por enchentes, inundações e deslizamentos quanto aos impactos sobre populações em situação de maior vulnerabilidade para agravamento de doenças e agravos não transmissíveis.
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1. Definir profissional para atuar como ponto focal nas ações de preparação e monitoramento relacionadas ao período chuvoso (nível regional e municipal); 2. Divulgar a Nota Técnica nº 1/SES/SUBRAS-SAPS/2026 que estabelece estratégias e recomendações para a preparação e resposta ao período chuvoso no âmbito da Rede de Atenção à Saúde no estado de Minas Gerais;

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3. Elaborar o Plano de Contingência do serviço, incluindo cenários de interrupção parcial ou total das atividades, bloqueio de vias de acesso ou indisponibilidade temporária de profissionais e equipamentos.
SETOR	AÇÕES
CIEVS	1. Manter a rotina habitual de detecção, triagem e verificação de rumores, por meio de mineração de dados contínua e sistemática de fontes oficiais e não oficiais para detecção precoce de eventos. 2. Manter a rotina de interlocução com os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE)/ Rede Renaveh 3. Articular com o CIEVS Nacional e outras instâncias da Rede CIEVS a troca de informações estratégicas sobre sinais, eventos e medidas de resposta. 4. Realizar capacitações para os NHE sobre elaboração de Planos de Contingência Hospitalares 5. Manter regime de plantão permanente (inclusive em fins de semana e feriados), garantindo o recebimento e análise oportuna de notificações de eventos, com pronta resposta a qualquer sinal de emergência em saúde pública. 6. Manter vigilância baseada em eventos, incluindo monitoramento de rumores, notificações, surtos e eventos de relevância em saúde pública relacionados à transmissão hídrica, alimentar, síndrome gripal/ síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, zoonóticas e outros agravos de relevância para saúde pública. 7. Manter fluxos de comunicação e articulação permanentes entre Vigilância Epidemiológica, Imunização, Vigilância em Saúde Ambiental, Atenção Primária à Saúde, Atenção Hospitalar, Rede de Urgência e Emergência, Laboratórios de Saúde Pública e Regulação do acesso aos serviços de saúde para preparação e resposta oportuna a potenciais emergências em saúde pública. 8. Apoiar a elaboração e atualização de planos de contingência, protocolos de resposta e instrumentos de preparação para enfrentamento de surtos e emergências relacionadas à escassez hídrica, contaminação da água para consumo humano, aumento de agravos respiratórios, sobrecarga do sistema ou desassistência e eventos ambientais extremos.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	9. Promover reuniões ordinárias do Comitê de Monitoramento de Eventos (CME) para acompanhamento dos eventos e análise de risco.

Estágio operacional de MOBILIZAÇÃO

QUADRO 06: Setores de atuação no estágio operacional de mobilização e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1. Mapear e monitorar os cenários de risco socioambiental junto às URS para identificar possíveis situações de desassistência à saúde na APS em cenários agravados. 2. Divulgar notas técnicas instruindo sobre os cadastros territoriais da APS com os mapas de risco dos órgãos de monitoramento. 3. Mapear, junto aos municípios, as rotas alternativas de acesso e pontos de apoio geográficos para o deslocamento seguro das equipes de APS. 4. Atualizar as relações nominais de usuários vulneráveis, incluindo dependentes de oxigenoterapia residentes nas áreas sob risco, assim como a listagem de salas de vacinação e UBS em áreas inundáveis ou sob perigo de deslizamento. 5. Prestar apoio institucional para a organização da logística de remoção preventiva de imunobiológicos em UBS inundáveis para polos seguros. 6. Realizar o monitoramento contínuo dos estoques de insumos essenciais (medicamentos, soros e vacinas) nas UBS, em articulação com as URS. 7. Auxiliar as URS no apoio técnico aos municípios para a revisão final e a implementação local dos Planos de Ação das UBS, priorizando as fases de preparação, cuidado e resposta imediata. 8. Fomentar junto aos municípios quanto à adequação das agendas internas e dos fluxos das UBS para otimizar o tempo de resposta e absorver o aumento de demandas agudas, definindo critérios claros de fluxo. 9. Estimular a busca ativa e as visitas domiciliares com base em protocolos de estratificação de risco para grupos prioritários e minorias.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	10. Planejar estratégias de bloqueio vacinal preventivo para tétano, hepatite A e influenza nas áreas suscetíveis a eventos hídricos, realizando diagnóstico da cobertura vacinal das próprias equipes de APS. 11. Articular e intensificar, por meio da atuação intersetorial e integrada entre ACS e ACE e em parceria com a Vigilância Ambiental, as ações de busca ativa de focos e criadouros de vetores em territórios, promovendo mutirões comunitários para eliminação de água parada, objetivando estratégias de educação em saúde para o manejo preventivo intra e peridomiciliar de arboviroses, zoonoses, doenças diarreicas agudas, leptospirose e acidentes por animais peçonhentos. 12. Elaborar e divulgar material técnico e normativo referente ao uso e fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em atividades de campo. 13. Prestar apoio institucional junto às URS no alinhamento da rotina de registros eletrônicos nos sistemas de informação para a captação de agravos sentinela. 14. Estabelecer fluxos de acionamento imediato e suporte matricial psicossocial junto aos profissionais das equipes da APS por meio do suporte das equipes eMulti. 15. Elaborar, atualizar e divulgar, junto às URS e áreas técnicas, o plano integrado de comunicação de risco e materiais educativos (impressos e digitais) direcionados à população, abordando a potabilidade da água, conservação de alimentos, guarda segura de medicamentos, manejo de animais peçonhentos e sinais de infecções. 16. Fomentar oficinas de planejamento nos territórios baseadas em problemas reais enfrentados pelas equipes para qualificar as ações emergenciais de educação em saúde. 17. Articular rodas de conversa comunitárias intermediadas por ACS para a transmissão de alertas meteorológicos e orientações preventivas de evacuação. 18. Incentivar o trabalho conjunto com as comunidades e apoiar o acionamento de redes de apoio (associações de bairro, voluntários, organizações religiosas e escolas) para atuar no monitoramento e na resposta coordenada em cenários agravados. 19. Fomentar e promover reuniões com conselheiros locais de saúde para a validação comunitária garantindo a transparência do plano de contingência da APS.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	20. Orientar as URS no planejamento de fluxos intersetoriais de articulação entre a APS, demais áreas da saúde e setores correlatos (como assistência social, educação, defesa civil e outras) para o atendimento integral das demandas de pacientes em vulnerabilidade.
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1. Manter atualizado o levantamento das bases do SAMU 192 (USB e USA) por território; 2. Revisar periodicamente os fluxos de acionamento do SAMU e do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV); 3. Monitorar a capacidade operacional das equipes (disponibilidade, cobertura e tempo-resposta); 4. Promover e acompanhar capacitações contínuas em urgência e emergência em desastres ocasionados por chuvas; 5. Validar e atualizar fluxos de transporte aeromédico previamente pactuados; 6. Fortalecer a articulação com a gestão regional do SAMU; 7. Realizar simulações ou exercícios de resposta a desastres ocasionados por chuvas.

SETOR	AÇÕES
SAÚDE MENTAL	1. Divulgar continuamente a Nota Técnica nº 3/SES/SUBRAS-SAE-DPE-CESMAD/2024 (https://www.saude.mg.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/PPR_Chuva-2024_ANEXO-A-Saude-mental-b9d.pdf) como referência orientadora; 2. Orientar os municípios quanto ao uso do formulário de atendimento em saúde mental em urgência; 3. Realizar e atualizar o diagnóstico situacional da RAPS - Rede de Atenção Psicossocial (serviços, equipes, vazios assistenciais); 4. Mapear pontos de atenção (ex.: Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, atenção básica, urgência) e fluxos assistenciais; 5. Elaborar e manter atualizados materiais informativos para profissionais e gestores; 6. Promover capacitações sobre cuidado em saúde mental em desastres. 7. Revisar fluxos de encaminhamento e contra referência; 8. Orientar sobre o correto uso do formulário de registro;
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1. Monitorar continuamente os estoques estratégicos de medicamentos e insumos prioritários para situações de desastres ocasionado por chuvas; 2. Verificar a capacidade logística de armazenamento e distribuição nas URS e municípios; 3. Manter atualizados os fluxos de solicitação, distribuição e reposição de medicamentos; 4. Capacitar equipes municipais e regionais sobre a Nota Técnica vigente, disponível no site do Ajuda SAF <https://ajudasaf.saude.mg.gov.br/54273-2/componente-estrategico/atendimento-a-calamidades/>; 5. Monitorar sistemas de informação para identificação de aumento de consumo ou demandas atípicas; 6. Articular com áreas técnicas para acompanhamento de riscos potenciais

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	1. Realizar monitoramento do número de casos suspeitos/confirmados de doenças e agravos relacionados às chuvas; 2. Atualizar fluxo para controle do número de casos suspeitos e confirmados de doenças e agravos relacionados às chuvas; 3. Promoção e comunicação em saúde: organizar divulgações de informações sobre doenças e agravos relacionados às chuvas; 4. Intensificar a situação epidemiológica dos acidentes por animais peçonhentos; 5. Intensificar o levantamento das necessidades de imunobiológicos; 6. Identificar casos de SG e realizar testagem para covid-19 (TR-antígeno). Orientar quanto as ações de prevenção a transmissão; 7. Orientar etiqueta respiratória em locais de aglomeração (abrigo, alojamentos, etc); 8. Fortalecer a coleta de amostras de RT PCR para covid-19, influenza e outros vírus respiratórios em todo caso de SRAG Hospitalizado ou óbito por SRAG garantindo investigação ampliada de vírus respiratórios; 9. Disponibilizar acesso a vacinas contra influenza, covid-19 e VSR ao público-alvo afetado; 10. Confirmar o funcionamento dos equipamentos da Rede de Frio, incluindo câmaras refrigeradas, geradores, nobreaks e termômetros; 11. Verificar a disponibilidade de caixas térmicas, bobinas reutilizáveis e demais insumos necessários para eventual remanejamento de imunobiológicos; 12. Revisar os fluxos de comunicação entre Estado, Regionais e municípios para notificação de interrupção de energia elétrica, alagamentos, excursões de temperatura e necessidade de remanejamento de imunobiológicos; 13. Avaliar a necessidade de antecipar a distribuição de imunobiológicos e insumos para municípios com risco de isolamento temporário;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	14- Reforçar junto aos municípios a importância do monitoramento contínuo da temperatura dos equipamentos e da adoção imediata dos protocolos em caso de excursão de temperatura; 15- Verificar a disponibilidade de estoque estratégico de imunobiológicos e insumos no âmbito estadual e regional para atendimento de demandas emergenciais; 16- Orientar os municípios para elaboração ou atualização de seus planos locais de contingência da Rede de Frio; 17- Intensificar o monitoramento das coberturas vacinais em áreas vulneráveis, priorizando ações preventivas quando necessário.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1. Apoiar na avaliação da ocorrência de danos nos serviços de abastecimento de água; 2. Apoiar no levantamento situacional da rede de laboratórios para o monitoramento da qualidade da água para consumo humano (insumos e equipamentos); 3. Apoiar na avaliação da necessidade de ampliação do plano de amostragem para vigilância e controle, considerando áreas de risco; 4. Fortalecer os fluxos de comunicação e intensificar a articulação intrasetorial e intersetorial; 5. Apoiar na intensificação das ações de saúde do trabalhador; 6. Reforçar orientações de preenchimento do Formulário de Notificação de Emergências/Catástrofes em Saúde Pública - SES/MG; 7. Encaminhar alertas para as Unidades Regionais de Saúde (SES) que possuem municípios com risco de inundação.
CIEVS	1. Monitorar continuamente eventos de interesse em saúde pública (doenças, agravos e desastres); 2. Acompanhar sistemas de informação (ex.: notificações, internações, óbitos); 3. Elaborar e atualizar painéis e boletins epidemiológicos de rotina;

SETOR	AÇÕES
CIEVS	4. Manter articulação com vigilâncias regionais e municipais; 5. Manter a rotina habitual de detecção, triagem e verificação de rumores, por meio de mineração de dados contínua e sistemática de fontes oficiais e não oficiais para detecção precoce de eventos. 6. Manter a rotina de interlocução com os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE)/ Rede Renaveh 7. Articular com o CIEVS Nacional e outras instâncias da Rede CIEVS a troca de informações estratégicas sobre sinais, eventos e medidas de resposta. 8. Realizar capacitações para os NHE sobre elaboração de Planos de Contingência Hospitalares 9. Manter regime de plantão permanente (inclusive em fins de semana e feriados), garantindo o recebimento e análise oportuna de notificações de eventos, com pronta resposta a qualquer sinal de emergência em saúde pública. 10. Manter vigilância baseada em eventos, incluindo monitoramento de rumores, notificações, surtos e eventos de relevância em saúde pública relacionados à transmissão hídrica, alimentar, síndrome gripal/ síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, zoonóticas e outros agravos de relevância para saúde pública. 11. Manter fluxos de comunicação e articulação permanentes entre Vigilância Epidemiológica, Imunização, Vigilância em Saúde Ambiental, Atenção Primária à Saúde, Atenção Hospitalar, Rede de Urgência e Emergência, Laboratórios de Saúde Pública e Regulação do acesso aos serviços de saúde para preparação e resposta oportuna a potenciais emergências em saúde pública. 12. Apoiar a elaboração e atualização de planos de contingência, protocolos de resposta e instrumentos de preparação para enfrentamento de surtos e emergências relacionadas à escassez hídrica, contaminação da água para consumo humano, aumento de agravos respiratórios, sobrecarga do sistema ou desassistência e eventos ambientais extremos. 13. Promover reuniões ordinárias do Comitê de Monitoramento de Eventos (CME) para acompanhamento dos eventos e análise de risco

SETOR	AÇÕES
SAÚDE DO TRABALHADOR	1. Planejar, conjuntamente com outras áreas da vigilância, ações voltadas à proteção da saúde dos trabalhadores expostos (Trabalhadores vinculados aos empreendimentos em risco; Bombeiros Militares e Civis; Profissionais da Defesa Civil; Profissionais de Saúde e de apoio aos serviços de saúde; Polícia Militar; Profissionais de Obras e Manutenção; Profissionais dos serviços de Limpeza Urbana; Profissionais da rede de Assistência Social; Profissionais dos transportes de cargas e pessoas); 2. Promover ações de educação em saúde e emitir comunicação de risco e recomendações de medidas de proteção e promoção direcionadas a trabalhadores, empregadores e equipes de saúde, com orientações sobre prevenção de doenças e agravos relacionadas às exposições de risco nos ambientes e processos de trabalho mais afetados pelo período chuvoso; 3. Apoiar o direcionamento, nos territórios afetados, de ações preventivas relacionadas à exposição às chuvas; 4. Intensificar o rastreamento e o monitoramento de grupos ocupacionais mais vulneráveis; 5. Fortalecer a articulação intersetorial com órgãos de meio ambiente, defesa civil, agricultura e setores produtivos, visando à atuação integrada frente aos riscos relacionados às chuvas.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS	1. Intensificar o monitoramento epidemiológico dos agravos acompanhados pela DVCC nos municípios sob risco de enchentes, inundações, alagamentos e outros eventos associados ao período chuvoso; 2. Identificar municípios com maior vulnerabilidade para interrupção do tratamento de tuberculose, hanseníase, HIV e outras condições que demandam acompanhamento contínuo; 3. Orientar as Unidades Regionais de Saúde e municípios quanto à adoção de medidas para manutenção do acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos agravos prioritários; 4. Intensificar a vigilância da hepatite A em áreas sob risco de inundação ou comprometimento do abastecimento de água; 5. Alertar os municípios para o monitoramento de situações de violência em contextos de desalojamento, desabrigamento e ocupação de abrigos temporários; 6. Orientar os municípios quanto à identificação e acompanhamento de pessoas em tratamento para tuberculose, hanseníase, HIV e outras condições crônicas que possam ter seu cuidado comprometido em decorrência de deslocamentos populacionais ou interrupção do funcionamento dos serviços de saúde.
SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1. Divulgar e manter atualizado o Plano de Contingência do serviço, incluindo cenários de interrupção parcial ou total das atividades, bloqueio de vias de acesso ou indisponibilidade temporária de profissionais e equipamentos; 2. Organizar estratégias para manutenção dos cuidados em reabilitação dos usuários na RAS, municipal e territorial.

Estágio operacional de ALERTA

QUADRO 07: Setores de atuação no estágio operacional de alerta e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.Realizar diagnóstico situacional em tempo real, mapeando e intensificando o monitoramento das salas de vacina situadas em áreas afetadas ou sob risco iminente de alagamentos, enchentes, enxurradas ou deslizamentos. 2.Avaliar a necessidade de reorganização temporária da oferta de vacinação de rotina, mapeando junto aos municípios as unidades alternativas viáveis diante do isolamento ou comprometimento das salas originais. 3.Prestar apoio institucional para o remanejamento de imunobiológicos e insumos estratégicos de unidades sob risco iminente de perda para evitar desabastecimentos. 4.Fomentar e implementar o fornecimento e a dispensação de hipoclorito de sódio e sais de reidratação oral (SRO) nas UBS localizadas nas áreas afetadas. 5.Orientar os municípios sobre a reorganização da agenda programática das unidades priorizando a demanda espontânea decorrente do cenário de desastre. 6.Divulgar notas técnicas sobre o acolhimento e o direcionamento de usuários com sintomas respiratórios e gastrointestinais nas dependências das UBS, estabelecendo fluxos rápidos de atendimento para verificação de sintomas de doenças de veiculação hídrica. 7.Otimizar a busca ativa domiciliar diária para gestantes no último trimestre e puérperas residentes em áreas inundáveis. 8.Manter o monitoramento e a identificação de idosos isolados ou que residem sozinhos nas áreas sob aviso de chuvas intensas. 9.Implementar e realizar o monitoramento clínico e epidemiológico, no e-SUS APS, de síndromes gripais, doenças diarreicas, leptospirose e arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika), identificando casos suspeitos para tomada de decisão rápida, conforme os protocolos assistenciais vigentes 10.Implementar e definir critérios de fluxos para a triagem de risco de insegurança alimentar (TRIA) nos atendimentos da APS afetada por eventos climáticos relacionados a chuva.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.Fomentar, implementar e planejar estratégias de teletriagem assistencial remota via telessaúde para acompanhamento contínuo dos grupos de risco do território para discussão remota dos agravos. 12.Apoiar na organização dos fluxos assistenciais de interface com outros pontos das Redes de Atenção à Saúde (RAS) para casos graves, com ênfase na Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) e na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 13.Orientar as URS na identificação e no estabelecimento de rede de referência para atendimento ambulatorial e hospitalar em locais seguros fora da mancha de inundação. 14.Elaborar material técnico detalhando o fluxo de notificação imediata à Vigilância Ambiental sobre alterações na água de torneira. 15.Elaborar material técnico focado em estratégias de comunicação de risco em saúde adaptadas especificamente para populações analfabetas ou com barreiras comunicacionais. 16.Promover reuniões de alinhamento com o Conselho de Saúde para capacitar lideranças no suporte à busca ativa territorial e na identificação e difusão de notícias falsas (Fake News) sanitárias.

SETOR	AÇÕES
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1. Intensificar a comunicação com a central de regulação do SAMU; 2. Colocar equipes e bases estratégicas em estado de prontidão; 3. Revisar e reforçar fluxos de acionamento para transporte terrestre e aeromédico; 4. Validar disponibilidade de aeronaves e equipes do SAAV; 5. Reforçar orientações operacionais para equipes locais e regionais; 6. Antecipar posicionamento de ambulâncias em áreas de maior risco; 7. Atualizar cenários e estimativas de demanda assistencial.
SETOR	AÇÕES
SAÚDE MENTAL	1. Reforçar a divulgação da Nota Técnica (https://www.saude.mg.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/PPR_Chuva-2024_ANEXO-A-Saude-mental-b9d.pdf) e dos fluxos assistenciais; 2. Reorientar os serviços da RAPS quanto à organização da resposta; 3. Validar equipes de referência para atuação em situações de emergência; 4. Intensificar a comunicação com municípios em risco; 5. Antecipar estratégias de cuidado para populações vulneráveis; 6. Identificar necessidade de ampliação de equipes ou suporte especializado.

SETOR	AÇÕES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1. Monitorar continuamente os estoques estratégicos de medicamentos e insumos prioritários para situações de desastres ocasionado por chuvas; 2. Revisar e, se necessário, adaptar fluxos logísticos previamente definidos; 3. Avaliar o cenário de risco e realizar o pré-posicionamento de medicamentos e insumos em áreas de maior risco; 4. Orientar municípios e URS quanto à aplicação da Nota Técnica vigente, disponível no site do Ajuda SAF <https://ajudasaf.saude.mg.gov.br/54273-2/componente-estrategico/atendimento-a-calamidades/>; 5. Validar capacidade de resposta (transporte, armazenamento e distribuição); 6. Estabelecer comunicação ativa com URS e municípios potencialmente afetados; 7. Iniciar levantamento preliminar de necessidades.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	1. Intensificar o monitoramento do número de casos suspeitos/confirmados de doenças e agravos relacionados às chuvas; 2. Intensificar as divulgações de informações sobre doenças e agravos relacionados às chuvas; 3. Intensificar o monitoramento da situação epidemiológica dos acidentes por animais peçonhentos; 4. Dar continuidade ao monitoramento das necessidades de imunobiológicos; 5. Elaborar análise epidemiológica; 6. Fortalecer e apoiar às Vigilâncias Epidemiológicas municipais sobre medidas de controle e prevenção que propiciem a redução do risco à saúde; 7. Identificar casos de SG e realizar testagem para covid-19 (TR-antígeno). Orientar quanto as ações de prevenção a transmissão; 8. Orientar etiqueta respiratória em locais de aglomeração (abrigo, alojamentos, etc);

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	9. Fortalecer a coleta de amostras de RT PCR para covid-19, influenza e outros vírus respiratórios em todo caso de SRAG Hospitalizado ou óbito por SRAG garantindo investigação ampliada de vírus respiratórios; 10. Disponibilizar acesso a vacinas contra influenza, covid-19 e VSR ao público-alvo afetado; 11. Monitorar, em tempo oportuno, interrupções no fornecimento de energia elétrica e seus impactos sobre a conservação dos imunobiológicos; 12. Orientar e acompanhar os municípios quanto à adoção dos protocolos para conservação dos imunobiológicos durante interrupções de energia elétrica e outras emergências; 13. Avaliar a necessidade de remanejamento preventivo de imunobiológicos para unidades seguras, quando houver risco de perda por alagamento ou comprometimento da Rede de Frio; 14. Disponibilizar apoio técnico às equipes municipais para avaliação de excursões de temperatura e definição da utilização ou descarte de imunobiológicos, conforme normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI); 15. Monitorar a disponibilidade de imunobiológicos, seringas, agulhas e demais insumos estratégicos, promovendo redistribuição quando necessário.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1. Articular com a comunicação social a divulgação de material educativo (cartilhas, folhetos e demais informações) no hotsite eletrônico Alerta Chuva; 2. Monitorar o fornecimento de energia e água para o funcionamento das unidades de saúde; 3. Realizar ações voltadas para a proteção da saúde dos trabalhadores expostos a riscos decorrentes do desastre, assim como dos trabalhadores envolvidos nas respostas à emergência; 4. Avaliar a manutenção da rede de frio (infraestrutura e equipamentos); 5. Planejar e distribuir hipoclorito de sódio 2,5% para tratamento da água; 6. Verificar e articular o acesso aos laboratórios para análises da qualidade da água;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	7. Colaborar nas articulações intersetoriais considerando a qualidade da água para consumo humano, como órgãos ambientais e de saneamento; 8. Garantir manutenção do fluxo de informações sobre o monitoramento de alerta de risco de inundação; 9. Orientar municípios para intensificação das ações de vigilância em saúde para detecção precoce de surtos; 10. Apoiar a intensificação das ações de vigilância da qualidade de água para consumo humano nos abrigos; 11. Apoiar a intensificação das ações de vigilância em saúde das populações expostas a substâncias químicas.
SETOR	AÇÕES
CIEVS	1. Intensificar o monitoramento de eventos e agravos relacionados ao desastre; 2. Emitir alertas epidemiológicos para municípios e regionais; 3. Produzir informes técnicos e boletins situacionais atualizados; 4. Estabelecer fluxo de comunicação ágil com municípios em risco; 5. Monitorar indicadores sensíveis (ex.: diarreias, leptospirose, acidentes) e produzir um Alerta Risco periódico para o setor saúde com informações relevantes ao evento; 6. Instaurar sala de situação, coordenando as reuniões intersetoriais com SubVS e as outras áreas da SES/MG, com reuniões semanais; 7. Avaliação do evento segundo o Regulamento Sanitário Internacional (RSI); 8. Avaliar os cenários de risco e recomendar medidas de preparação e resposta, incluindo a ativação de Centros de Operações de Emergência (COE).

SETOR	AÇÕES
SAÚDE DO TRABALHADOR	1. Emitir comunicação de risco em nível local com orientações específicas voltadas à proteção da saúde dos trabalhadores expostos aos efeitos das chuvas; 2. Executar ações de prevenção, promoção e proteção à saúde dos trabalhadores expostos nos ambientes e processos de trabalho; priorizando grupos ocupacionais e atividades econômicas mais vulneráveis; 3. Monitorar a ocorrência e tendência de doenças e agravos relacionados ao trabalho, com ênfase nos eventos associados às chuvas, inundações, alagamentos e enxurradas; 4. Investigar e notificar doenças e agravos relacionados ao trabalho nos sistemas do SUS, promovendo a qualificação e a oportunidade dos registros; 5. Solicitar, se necessário, apoio técnico, para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) Regional (para municípios da área de abrangência de CEREST), para a assistência especializada em saúde do trabalhador e para as ações de vigilância; 6. Apoiar e, quando necessário, executar inspeções sanitárias em ambientes e processos de trabalho com maior risco, visando à adoção de medidas imediatas de controle e mitigação; 7. Fortalecer a articulação intersetorial com órgãos de defesa civil, meio ambiente, saneamento e setores produtivos, para resposta coordenada aos impactos das chuvas sobre a saúde dos trabalhadores.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE CONDIÇÕES CRÔNICAS	1. Intensificar o monitoramento dos impactos potenciais dos eventos climáticos sobre o tratamento e acompanhamento das pessoas com tuberculose, hanseníase, HIV, hepatites virais, IST e doenças crônicas; 2. Orientar os municípios quanto à adoção de medidas para redução do risco de interrupção de tratamentos e perda de seguimento dos casos em acompanhamento; 3. Intensificar a vigilância epidemiológica da hepatite A e de possíveis surtos associados à contaminação hídrica; 4. Produzir análises situacionais e informes epidemiológicos para subsidiar a tomada de decisão;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE CONDIÇÕES CRÔNICAS	5. Orientar os municípios quanto à vigilância e notificação de situações de violência em abrigos e outros contextos de vulnerabilidade decorrentes do desastre; 6. Orientar os municípios quanto à detecção oportuna, investigação e notificação de casos suspeitos de hepatite A em áreas sob risco de inundação ou comprometimento da qualidade da água.
SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1. Elaborar a triagem interna, pela equipe multiprofissional, para priorização e definição dos usuários com casos clínicos funcionais que necessitem da manutenção dos atendimentos presenciais em reabilitação; 2. Identificar usuários com deficiência residentes em áreas rurais isoladas, comunidades tradicionais ou abrigos temporários, e priorizar estratégias de transporte sanitário, telemonitoramento e busca ativa, minimizando interrupções no cuidado; 3. Realizar o levantamento e avaliação dos recursos municipais disponíveis no setor saúde/reabilitação (estrutura física, recursos humanos, equipamentos, suprimentos, transportes) e organizar o fluxo assistencial na RAS para continuidade dos atendimentos presenciais em outros pontos de atenção, mantendo-se o compartilhamento do cuidado dos usuários.

Estágio operacional de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

QUADRO 08: Setores de atuação no estágio operacional de situação de emergência e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1. Realizar diagnóstico situacional identificando danos estruturais imediatos nas UBS, documentando a paralisação de serviços básicos e novos cenários de risco com iminente desassistência à saúde na APS. 2. Divulgar notas técnicas orientando o redirecionamento tático das equipes cujas UBS foram inviabilizadas pelo desastre, reposicionando os profissionais para prestar assistência direta em apoio aos desabrigados e desalojados. 3. Prestar apoio institucional para o deslocamento de equipes volantes da APS voltadas ao atendimento médico e vacinal em abrigos e alojamentos temporários. 4. Orientar os municípios na estruturação emergencial de salas de reidratação oral e suporte inalatório dentro das instalações remanescentes e unidades de saúde disponíveis. 5. Reorganizar, em conjunto com os gestores locais, a oferta e a logística da vacinação em unidades temporárias ou estruturas alternativas na emergência, planejando estratégias de vacinação itinerante extramuros em áreas críticas para mitigar o risco de surtos secundários de doenças imunopreveníveis. 6. Apoiar tecnicamente as equipes municipais no restabelecimento e na retomada gradual das atividades de vacinação de rotina nos territórios e localidades onde as condições de segurança forem sendo normalizadas. 7. Orientar na atualização diária e consolidação dos cadastros individuais no e-SUS APS dos usuários desabrigados e desalojados no território, realizando o monitoramento diário da migração de dados dos dispositivos móveis do e-SUS Território para o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). 8. Fomentar e instituir protocolos operacionais para a triagem e o registro assistencial manual, garantindo a posterior consolidação retroativa no prontuário eletrônico (PEC/e-SUS APS) em cenários de queda de conectividade, interrupção de energia elétrica ou perda física de equipamentos decorrentes das enchentes, de modo a assegurar o registro dos dados de atendimento das populações afetadas e das equipes remanejadas.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.Fomentar e implementar o fluxo rápido de triagem clínica (Fast-Track) na UBS para identificação precoce de casos suspeitos pós-enchentes, estabelecendo critérios para o início do tratamento de leptospirose com base em sinais clínicos. 10.Fomentar a manutenção e continuidade do cuidado domiciliar de saúde para acamados, restritos ao leito e oxigênio-dependentes nas áreas afetadas. 11.Elaborar material técnico instruindo as equipes da APS sobre procedimentos de curativos e profilaxia antitetânica de urgência em lesões por destroços, além de atualizar protocolos assistenciais para manejo e tratamento de surtos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) nos abrigos. 12.Mapear junto aos municípios os pontos de referência da APS para facilitação do atendimento em acidentes por animais peçonhentos desalojados. 13.Estabelecer fluxos de articulação assistencial da APS com os complexos de regulação clínica regionais e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para suporte e transporte de casos moderados e graves. 14.Estabelecer fluxos para emissão imediata de segundas vias de cartões de vacina e receitas médicas perdidas pelos usuários afetados pelo desastre. 15.Promover o acolhimento psicossocial e cuidados de saúde mental na APS em articulação estreita com as equipes eMulti nos alojamentos. 16.Fomentar e implementar de forma intersetorial, nos abrigos e pontos de atendimento montados na emergência, condições de acessibilidade física e comunicacional para os usuários com deficiência e limitação de mobilidade previamente identificados na fase de preparação, priorizando seu acesso e atendimento nas estruturas provisórias. 17.Articular de forma intersetorial o fornecimento emergencial de medicamentos de uso contínuo para desabrigados portadores de condições crônicas, viabilizando ações integradas de promoção da saúde e prevenção de agravos, otimizando a logística de distribuição desses fármacos e de kits de higiene bucal diretamente nos alojamentos e assegurar o monitoramento e o controle da dispensação e do estoque dos insumos durante toda a fase de emergência. 18.Fomentar, nos territórios, ação de educação em saúde, organizando as ações de vigilância nutricional e antropométrica em menores de 5 anos em áreas desabastecidas.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	19. Elaborar e atualizar material educativo de distribuição física nos abrigos contendo técnicas de desinfecção intradomiciliar da água de consumo. 20. Promover ações diretas de comunicação de risco dentro dos alojamentos temporários, alertando sobre a detecção de surtos diarreicos e respiratórios e mantendo a população informada sobre as unidades de saúde disponíveis, horários de funcionamento e fluxos assistenciais das UBS. 21. Intensificar, junto aos municípios e URS, o acompanhamento em tempo real das ações básicas e da busca ativa executadas pelas eSF, garantindo o suporte técnico necessário à assistência. 22. Estabelecer fluxos de escuta e captação de demandas das comissões de desabrigados para aperfeiçoar continuamente o acolhimento à saúde prestado pela APS. 23. Manter a transparência e o controle social por meio de informativos diários aos conselheiros locais de saúde contendo o balanço consolidado de atendimentos nos abrigos e territórios. 24. Realizar ações de educação em saúde e distribuir hipoclorito de sódio para tratamento da água à população, por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
SETOR	AÇÕES
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1. Orientar na Execução do transporte de vítimas por meio terrestre e/ou aeromédico (SAAV); 2. Orientar na triagem e priorização de atendimentos conforme gravidade; 3. Articular com as Centrais de Regulação do SAMU e os consórcios gestores a reorganização do posicionamento das ambulâncias e equipes, priorizando as áreas mais críticas, conforme protocolos e disponibilidade operacional. 4. Manter comunicação contínua com a central de regulação; 5. Apoiar municípios e URS na organização da resposta pré-hospitalar; 6. Monitorar em tempo real a demanda e capacidade de resposta; 7. Registrar atendimentos e deslocamentos para monitoramento e avaliação.

SETOR	AÇÕES
SAÚDE MENTAL	1. Auxiliar na implementação atendimento psicossocial nos territórios afetados (abrigos, unidades de saúde, campo); 2. Ativar equipes da RAPS conforme fluxos estabelecidos; 3. Orientar os municípios e URS quanto a priorização dos grupos vulneráveis (crianças, idosos, desabrigados, enlutados); 5. Auxiliar na organização do acolhimento, escuta qualificada e manejo de crises agudas; 6. Apoiar tecnicamente os municípios na organização da atenção em saúde mental; 7. Monitorar demandas e agravos psicossociais emergentes; 8. Integrar ações com atenção básica, urgência e assistência social.
SETOR	AÇÕES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1. Apoiar tecnicamente as URS na solicitação do Kit de Medicamentos e Insumos Estratégicos; 2. Em articulação com municípios e regionais, viabilizar a reposição de medicamentos devido às perdas ocorridas, independentemente da solicitação de kits ao Ministério da Saúde, conforme previsto em Nota Técnica vigente, disponível no site do Ajuda SAF https://ajudasaf.saude.mg.gov.br/54273-2/componente-estrategico/atendimento-a-calamidades/; 3. Auxiliar os municípios nas demandas de medicamentos para outros agravos não contemplados nos fluxos existentes e viabilizar cessão por parte do Ministério da Saúde, sempre que possível; 4. Implantar controle simplificado e ágil de entrada/saída de medicamentos; 5. Reorganizar fluxos logísticos conforme disponibilidade real de recursos; 6. Priorizar atendimento a populações vulneráveis (desabrigados/desalojados); 7. Monitorar consumo em tempo real para reposição rápida;

SETOR	AÇÕES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8. Apoiar tecnicamente as URS na organização da assistência farmacêutica dos municípios; 9. Registrar todas as ações para fins de monitoramento e prestação de contas; 10. Articular com outras áreas (atenção à saúde, vigilância, logística).
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	1. Avaliar a manutenção da rede de frio (infraestrutura e equipamentos); 2. Verificar necessidade de apoio presencial da área técnica da leptospirose no município e URS; 3. Manter monitoramento do número de casos suspeitos/confirmados de doenças e agravos relacionados às chuvas; 4. Promoção e comunicação em saúde: organizar a divulgações de informações sobre a doença para população; 5. Orientar acerca de medidas de prevenção e controle para os acidentes por animais peçonhentos que podem estar associadas ao evento; 6. Realizar o monitoramento do recebimento, da autorização e do envio dos pedidos emergências e de rotina dos imunobiológicos; 7. Elaboração de Planos de Ação com estratégias de vacinação e atualização de caderneta; 8. Monitorar o risco de transmissão de doenças respiratórias devido à aglomeração de pessoas (alojamentos, abrigos, dentre outros) e orientar quanto ao isolamento de doentes; 9. Liberar testes rápidos de antígeno (TR Ag covid-19) aos municípios conforme disponibilidade e fluxo estabelecido pela SES; 10. Articular com instituições parceiras o desenvolvimento das ações necessárias; 11. Apoiar tecnicamente os municípios na adoção de medidas para conservação dos imunobiológicos utilizando geradores, caixas térmicas e outras estratégias previstas nos protocolos do PNI;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	12. Avaliar e acompanhar todas as excursões de temperatura ocorridas durante a emergência, orientando quanto à utilização, quarentena ou descarte dos imunobiológicos.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1. Intensificar as ações previstas no cenário de alerta; 2. Articular estratégias para fornecimento de insumos e equipamentos para monitoramento da qualidade da água para consumo humano; 3. Articular parcerias, definir fluxos e responsabilidades para a coleta e análise de amostras de água para consumo humano; 4. Orientar sobre a utilização de tecnologias Intra domiciliares de tratamento de água para consumo humano em situações de emergências; 5. Orientar sobre a requisição de recursos de incremento financeiro para custeio das ações de resposta junto ao Ministério da Saúde de acordo com as normativas vigentes; 6. Envio de equipes técnicas, ativação plena dos planos de resposta ou planos de contingência; 7. Monitorar o fornecimento de energia e água para o funcionamento das unidades de saúde; 8. Produzir boletins diários (ou mais frequentes) da situação epidemiológica conjuntamente com o CIEVS; 9. Distribuir hipoclorito de sódio 2,5% para tratamento Intra domiciliar da água; 10. Verificar e articular o acesso aos laboratórios para análises da qualidade da água; 11. Colaborar nas articulações intersetoriais sobre qualidade da água (órgãos ambientais e saneamento); 12. Avaliar dados epidemiológicos de doenças de transmissão hídrica e qualidade da água; 13. Prestar apoio local em caso de necessidade ou calamidade ou quando o evento exceder a capacidade de resposta municipal, ativação da Força Estadual

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	de Saúde; 14. Participação no Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE); 15. Articulação com as áreas técnicas do setor saúde e demais órgãos, quando necessário; 16. Orientar tecnicamente municípios quanto à vigilância e notificação.
SETOR	AÇÕES
GESTÃO SES	1. Ativar o Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE), em parceria com o CIEVS, mediante resolução do Gabinete, formalizando a ativação a partir da avaliação de necessidade e da articulação técnica prévia realizada pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde; 2. Intensificar a articulação e o apoio técnico junto às SES/SMS para o desenvolvimento das ações de saúde estabelecidas no Plano de Contingência para Enfrentamento ao Período Chuvoso ou documento equivalente, com base nos subsídios técnicos fornecidos pela SUBVS; 3. Fortalecer o desenvolvimento de ações intersetoriais e interinstitucionais, a partir da articulação promovida pela SUBVS junto ao Gabinete; 4. Autorizar e formalizar o acionamento dos Protocolos de Cooperação Interinstitucional para a implementação das ações, mediante provocação da SUBVS.
GESTÃO SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1. Encaminhar equipes para apoio técnico na resposta, quando necessário, acionando o Gabinete quando a mobilização exigir formalização institucional; 2. Ativar o Plano de Contingência para o enfrentamento ao período chuvoso; 3. Articular com os diretores e coordenadores das áreas de atuação para o atendimento oportuno à emergência; 4. Identificar a necessidade de recursos adicionais (materiais e humanos) e acionar o Gabinete, fornecendo os subsídios técnicos necessários para viabilizar seu envio; 5. Acompanhar o desenvolvimento das ações de saúde estabelecidas no Plano de Contingência para Enfrentamento ao Período Chuvoso, mantendo o Gabinete informado.

SETOR	AÇÕES
CIEVS	1. Apoiar a operacionalização do Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE), em conjunto com a SubBS, coordenando o fluxo de informações estratégicas e decisões operacionais.; 2. Apoiar a formulação de planos de gestão multirrisco e unidades de resposta; 3. Notificar e intercambiar informações com o Ministério da Saúde e Rede CIEVS; 4. Elaborar Plano de Ação para o Evento, em conjunto com áreas técnicas; 5. Receber, verificar e consolidar os alertas provenientes das URS, municípios e unidades hospitalares, priorizando a identificação de eventos críticos (óbitos, surtos em populações vulneráveis, internações graves, falta de insumos).; 6. Elaborar boletins epidemiológicos diários ou semanais (de acordo com o cenário epidemiológico), em conjunto com o Vigidesastres, para atualização da Rede de Vigilância em Saúde; 7. Apoiar tecnicamente às SMS e URS para manutenção da vigilância e resposta local; 8. Apoiar investigação de surtos e eventos inusitados; 9. Monitorar agravos prioritários em articulação com as áreas técnicas e Programa VigiDesastres;

SETOR	AÇÕES
SAÚDE DO TRABALHADOR	1. Participar de salas de situação e Centro de Operações de Emergências (COE), contribuindo com informações técnicas relacionadas à saúde do trabalhador; 2. Intensificar a vigilância das doenças e agravos relacionados ao trabalho, com monitoramento contínuo da ocorrência, distribuição e tendência dos eventos nos territórios afetados; 3. Apoiar ações emergenciais de proteção aos trabalhadores, especialmente aqueles envolvidos na resposta à crise, como equipes de abastecimento de água, limpeza urbana, saúde, defesa civil e outros serviços essenciais; 4. Solicitar, se necessário, apoio técnico, para o CEREST Regional (para municípios da área de abrangência de CEREST), para a assistência especializada em saúde do trabalhador e para as ações de vigilância; 5. Recomendar e monitorar a adoção de medidas de proteção coletiva e individual nos ambientes e processos de trabalho, considerando os riscos agravados pelas chuvas e pelas condições sanitárias críticas; 6. Apoiar a realização de inspeções sanitárias em ambientes de trabalho prioritários e em estruturas temporárias para alojamento de trabalhadores, visando à mitigação imediata dos riscos à saúde dos trabalhadores; 7. Fortalecer a articulação intersetorial com órgãos de defesa civil, saneamento, meio ambiente e demais setores envolvidos na resposta à emergência; 8. Apoiar os serviços de saúde na identificação, manejo e notificação de agravos relacionados ao trabalho, assegurando a integração entre vigilância e assistência.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS	1. Monitorar os impactos do desastre sobre a continuidade do tratamento e acompanhamento das pessoas com tuberculose, hanseníase, HIV, hepatites virais, IST e doenças crônicas; 2. Apoiar tecnicamente os municípios na identificação de situações de interrupção de tratamento, desassistência e perda de seguimento em conjunto com a Atenção Primária; 3. Intensificar a vigilância da hepatite A e apoiar a investigação de casos e surtos relacionados ao evento; 4. Monitorar e apoiar tecnicamente os municípios quanto às notificações de situações de violência associadas ou agravadas pelo desastre, especialmente em abrigos temporários e populações vulnerabilizadas; 5. Subsidiar o COE e a Sala de Situação com análises epidemiológicas relacionadas aos agravos acompanhados pela DVCC; 6. Produzir orientações técnicas e recomendações para manutenção do cuidado e redução dos riscos à saúde da população afetada; 7. Orientar os municípios quanto à vigilância de agravos e situações de vulnerabilidade em abrigos temporários, especialmente relacionados à tuberculose, hepatite A e violências; 8. Comunicar oportunamente às áreas responsáveis situações que possam comprometer o acesso a medicamentos e insumos estratégicos utilizados no tratamento e prevenção dos agravos acompanhados pela DVCC.
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1. Atualizar e divulgar, pelos canais disponíveis, informações sobre funcionamento do serviço, possíveis mudanças de agenda, orientações sobre exames e ações remotas; 2. Reforçar a triagem interna, pela equipe multiprofissional, para priorização e definição dos usuários com casos clínicos funcionais que necessitem da manutenção dos atendimentos presenciais em reabilitação; 3. Manter as Juntas Reguladoras da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Referências Técnicas Municipais cientes e participativas nos processos de alterações de fluxos assistenciais e horários de atendimentos nos serviços especializados da rede.

QUADRO 09: Setores de atuação no estágio operacional de crise e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1. Prestar apoio institucional na avaliação técnica e consolidação de danos estruturais e funcionais dos serviços de saúde da rede de APS, identificando prejuízos físicos junto aos municípios e às URS. 2. Mapear junto aos municípios as áreas inundadas, cruzando mapas estruturais com dados georreferenciados gerados a partir do e-SUS Território e do SIAPS para fins de planejamento reconstrutivo. 3. Realizar diagnóstico situacional da rede de assistência à saúde de forma ascendente e territorializada, integrando os dados da Vigilância em Saúde (VS) e da APS para qualificar as tomadas de decisão estruturais. 4. Planejar estratégias de resposta a nós críticos causais identificados no território. 5. Fomentar e implementar unidades de atendimento básico provisórias ou serviços móveis em terrenos seguros para garantir o acesso ininterrupto de populações isoladas. 6. Articular e definir junto aos municípios critérios de fluxos para a reestruturação tática da força de trabalho da APS em regime excepcional de plantão e horários estendidos, promovendo a flexibilização das escalas das equipes expostas a alta sobrecarga emocional para a prevenção do esgotamento profissional (burnout). 7. Estabelecer fluxos estáveis de insumos e medicamentos essenciais por meio do apoio compartilhado e articulação com consórcios intermunicipais de saúde. 8. Atualizar as bases cadastrais do CNES dos municípios e garantir a identificação de usuários afetados via CPF ou número de CNS no CadSUS Web. 9. Divulgar notas técnicas orientando a transferência de dados consolidados de atendimentos para os sistemas nacionais de informação, monitorando diariamente a migração de dados locais. 10. Manter o suprimento assistencial e o monitoramento de saúde básico nos alojamentos temporários de forma ininterrupta, orientando os municípios quanto ao acolhimento prioritário dos grupos vulnerabilizados por meio de

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	escuta qualificada para o manejo oportuno e efetivo das demandas. 11. Atualizar e disponibilizar protocolos assistenciais de telessaúde para profissionais em regime de trabalho remoto efetuarem a renovação programada de receitas on-line. 12. Realizar monitoramento epidemiológico contínuo de surtos de doenças transmissíveis pós-inundação e indicadores de morbidade nos abrigos para subsidiar as ações do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE). 13. Definir as prioridades técnicas para a oferta de vacinação no território, considerando o cenário epidemiológico, a vulnerabilidade das populações afetadas e a capacidade operacional local restante. 14. Implantar estratégias extraordinárias e temporárias de vacinação de rotina e de bloqueio em abrigos, unidades móveis, serviços provisórios ou outras estruturas alternativas disponibilizadas na emergência. 15. Manter a comunicação de risco ativa através de canais digitais institucionais para dar ampla publicidade e orientação sobre as UBS provisórias montadas e o funcionamento da rede. 16. Fomentar, nos territórios, ações de educação em saúde, organizando os Núcleos de Educação Permanente em Saúde (NEPS) para qualificar os trabalhadores frente às crises hídricas e sanitárias. 17. Definir critérios de fluxo para a recepção e o processamento de denúncias ou demandas de desassistência, utilizando os canais de ouvidoria e os conselheiros de saúde como sensores territoriais. 18. Fomentar e orientar os municípios na prestação de contas das ações da APS em plenárias do Conselho Municipal de Saúde, fortalecendo a transparência e o controle social. 19. Participar e articular junto as URS de forma intermunicipal ou interfederativa o reforço de recursos humanos mediante a incapacidade da gestão municipal da APS na fase de crise. 20. Apoiar as URS na articulação intermunicipal e interfederativa para o remanejamento temporário de profissionais de saúde, suprimindo o déficit de força de trabalho e reforçando a assistência na APS nos territórios afetados.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	21. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas.
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1. Orientar na reorganização da rede de urgência e emergência conforme capacidade disponível; 2. Orientar na priorização de atendimentos de maior gravidade (classificação de risco rigorosa); 4. Auxiliar no uso do transporte aeromédico quando necessário; 5. Auxiliar na Implantação de estratégias excepcionais (postos avançados, atendimento em campo); 6. Integrar ações com Corpo de Bombeiros e demais forças de resposta; 7. Operar em gabinete de crise com participação da regulação; 8. Consolidar dados para tomada de decisão. 9. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas.
SETOR	AÇÕES
SAÚDE MENTAL	1. Reorganizar a RAPS para atendimento ampliado e contínuo; 2. Auxiliar na implantação de estratégias coletivas de cuidado (grupos, apoio comunitário); 4. Auxiliar na priorização de casos graves (transtornos agudos, risco de suicídio, luto intenso); 5. Auxiliar na garantia da continuidade do cuidado pós-evento; 6. Atuar em gabinete de crise com inserção da saúde mental; 7. Intensificar monitoramento de agravos psicossociais; 8. Consolidar registros e avaliar impacto para planejamento futuro;

SETOR	AÇÕES
SAÚDE MENTAL	9. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas.
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1. Atuar em gabinete de crise com participação ativa da assistência farmacêutica; 2. Solicitar apoio federal e de parceiros institucionais, se necessário; 3. Implantar estratégias excepcionais de dispensação (kits, protocolos simplificados); 4. Avaliar disponibilidade de financiamento e execução do projeto de saúde para a Política Estadual de Assistência Farmacêutica Ambulatorial no âmbito das Redes de Atenção à Saúde - Farmácia de Minas, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes de farmácia pública no município; 5. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	1. Avaliar a manutenção da rede de frio (infraestrutura e equipamentos); 2. Verificar necessidade de apoio presencial da área técnica da leptospirose no estado e/ou município; 3. Manter monitoramento do número de casos suspeitos/confirmados de doenças e agravos transmissíveis relacionados às chuvas; 4. Promoção e comunicação em saúde: organizar a divulgação de informações sobre a doença para população; 5. Prover orientações técnicas acerca de medidas de prevenção e controle para os acidentes por animais peçonhentos que podem estar associadas ao evento, em conjunto com a ASCOM; 6. Sensibilizar o sistema de vigilância sobre a possibilidade de aumento de casos de acidentes por animais peçonhentos em áreas com chuvas intensas ou possibilidade de extrapolação da cota de inundação; 7. Verificar a situação do estoque de antivenenos para atender as necessidades das áreas possivelmente afetadas;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	8. Realizar o monitoramento do recebimento, da autorização e do envio dos pedidos de emergências e de rotina dos imunobiológicos; 9. Elaboração de Planos de Ação com estratégias de vacinação e atualização de caderneta; 10. Avaliar a necessidade de encaminhamento de equipe técnica para auxiliar na resposta ao evento in loco; 11. Desenvolver ações de vacinação para interromper cadeia de transmissão de doenças imunopreveníveis; 12. Monitoramento a situação epidemiológica de doenças respiratórias (covid-19, influenza e OVR) relacionados à inundação; 13. Monitorar o risco de transmissão de doenças devido à aglomeração de pessoas (alojamentos, abrigos, dentre outros) e orientar quanto ao isolamento de doentes; 15. Identificar casos de SG e realizar testagem para covid-19 (TR-antígeno). Orientar quanto as ações de prevenção a transmissão; 16. Orientar etiqueta respiratória em locais de aglomeração (abrigos, alojamentos, etc); 17. Fortalecer a coleta de amostras de RT PCR para covid-19, influenza e outros vírus respiratórios em todo caso de SRAG Hospitalizado ou óbito por SRAG garantindo investigação ampliada de vírus respiratórios; 18. Disponibilizar acesso a vacinas contra influenza, covid-19 e VSR ao público-alvo afetado; 19. Manter ativado o Plano de Contingência da Rede de Frio e participar das ações coordenadas pelo Centro de Operações de Emergências (COE); 20. Priorizar a manutenção da cadeia de frio, adotando medidas excepcionais para conservação, armazenamento e transporte dos imunobiológicos; 21. Coordenar o remanejamento interestadual, regional e municipal de imunobiológicos e insumos estratégicos, conforme disponibilidade e necessidade;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	22. Solicitar apoio ao Ministério da Saúde para reposição emergencial de imunobiológicos, insumos e suporte técnico, quando necessário; 23. Planejar e executar ações de recuperação pós-crise, incluindo reposição de estoques, avaliação das perdas, retomada das coberturas vacinais e intensificação da vacinação nas áreas afetadas. 24. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1. Realizar as ações previstas no cenário de situação de emergência; 2. Articular estratégias para disponibilização de unidades móveis de tratamento de água; 3. Articular estratégias para fornecimento e distribuição de água para consumo humano; 4. Manutenção de equipes técnicas, ativação plena do Plano de Contingência para Enfrentamento ao Período Chuvoso; 5. Ativação plena e contínua do COE com gestão integrada e multissetorial; 6. Executar as estratégia de comunicação intra e intersectorial; 7. Analisar dados epidemiológicos e definir prioridades; 8. Garantir fluxo de informações sobre riscos e monitoramento; 9. Elaborar informes técnicos periódicos situacionais em conjunto com o CIEVS; 10. Coordenação intersectorial intensificada com órgãos estaduais, municipais e federais; 11. Apoio intensificado a municípios com superação da capacidade de resposta local, com apoio da Força Estadual de Saúde e/ou Ministério da Saúde; 12. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas.

SETOR	AÇÕES
GESTÃO SES	1. Manter/formalizar a ativação do COE mediante resolução do Gabinete, com base na avaliação de necessidade e na articulação técnica contínua da SUBVS; 2. Estabelecer mecanismo de acompanhamento das ações do Plano de Contingência para Enfrentamento ao Período Chuvoso, por meio de acompanhamento conjunto entre todas as Subsecretarias envolvidas, garantindo a supervisão das equipes de resposta e a execução das atividades previstas; 3. Autorizar a mobilização dos recursos identificados como necessários pela SUBVS para as ações de resposta à crise; 4. Informar as áreas e órgãos envolvidos na resposta à emergência sobre a situação de saúde da região afetada e as ações de resposta desenvolvidas no âmbito da saúde; 5. Realizar, mediante provocação e subsídios técnicos da SUBVS, o alinhamento institucional junto ao Governo do Estado para eventual declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin).
GESTÃO SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1. Garantir a continuidade da articulação junto à Secretaria de Estado de Saúde e às Secretarias Municipais de Saúde; 2. Identificar a necessidade de recursos adicionais (materiais e humanos) para o atendimento à crise e acionar o Gabinete, articulando com o COE o respectivo envio; 3. Apoiar o COE na articulação com a Coordenação da Força Estadual do SUS para o envio de equipe, acionando o Gabinete quando necessário; 4. Avaliar a necessidade de declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) e, quando pertinente, acionar o Gabinete da SES, fornecendo os subsídios técnicos necessários para o alinhamento junto ao Governo do Estado; 5. Apoiar o COE na resolução de conflitos e dificuldades encontradas na etapa de resposta; 6. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas.

SETOR	AÇÕES
CIEVS	1. Atuar como núcleo central de articulação, comunicação e gestão da resposta, em estreita cooperação com as áreas técnicas; 2. Coordenar reuniões diárias do COE com participação de múltiplos setores; 3. Gerir fluxo de comunicação de risco em parceria com a assessoria de comunicação da SES-MG, assegurando coerência e agilidade na divulgação de informações oficiais; 4. Elaborar relatórios estratégicos para subsidiar decisões da gestão estadual; 5. Promover a integração com Defesa Civil, Secretaria de Governo e outros órgãos; 6. Emitir de alertas e informes situacionais às instâncias estaduais e federais, promovendo comunicação tempestiva com o CIEVS Nacional e o COE do MS; 7. Manter monitoramento em tempo oportuno com alta frequência de atualização; 8. Produzir análises estratégicas para subsidiar o COE; 9. Intensificar comunicação de risco para gestores e população; 10. Integrar dados intersetoriais (saúde, defesa civil, assistência social); 11. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas.

SETOR	AÇÕES
SAÚDE DO TRABALHADOR	1. Monitorar continuamente os impactos severos à saúde dos trabalhadores, com análise da magnitude, distribuição e tendência das doenças e agravos relacionados ao trabalho; 2. Intensificar a vigilância das doenças e agravos relacionados ao trabalho, assegurando a detecção oportuna, investigação e notificação nos sistemas de informação do SUS; 3. Solicitar, se necessário, apoio técnico, para o CEREST Regional (para municípios da área de abrangência de CEREST), de forma a garantir a assistência especializada em saúde do trabalhador e para as ações de vigilância; 4. Solicitar, conforme necessidade, apoio do Ministério da Saúde para a realização de ações estratégicas de promoção e prevenção à saúde dos trabalhadores; 5. Intensificar a realização das inspeções sanitárias em saúde do trabalhador nos ambientes e processos de trabalho prioritários e em estruturas temporárias para alojamento de trabalhadores, com foco na adoção imediata de medidas de controle e mitigação dos riscos; 6. Apoiar e executar ações emergenciais de proteção à saúde dos trabalhadores, especialmente aqueles envolvidos na resposta à crise e na manutenção de serviços essenciais; 7. Recomendar, implementar e monitorar medidas de proteção coletiva e individual, considerando os riscos extremos decorrentes das chuvas e do colapso dos serviços; 8. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas. 9. Fortalecer a articulação intersetorial em nível ampliado (estadual e, quando necessário, federal), com órgãos de defesa civil, saneamento, meio ambiente e demais setores estratégicos.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE CONDIÇÕES CRÔNICAS	1. Intensificar o monitoramento dos impactos do desastre sobre a morbimortalidade e a continuidade do cuidado dos agravos acompanhados pela DVCC; 2. Identificar e monitorar situações críticas de interrupção de tratamento,]desabastecimento de insumos estratégicos e perda de seguimento dos casos; 3. Apoiar tecnicamente os municípios na implementação de estratégias emergenciais para manutenção do tratamento e acompanhamento dos usuários; 4. Intensificar a vigilância e resposta aos surtos de hepatite A relacionados à contaminação hídrica; 5. Intensificar o monitoramento e a resposta às situações de violência associadas ao desastre, especialmente em abrigos e populações vulnerabilizadas; 6. Produzir análises epidemiológicas periódicas para subsidiar a tomada de decisão e a priorização das ações de resposta; 7. Avaliar os impactos do evento sobre os indicadores de saúde relacionados aos agravos acompanhados pela DVCC e subsidiar o planejamento das ações de recuperação pós-desastre; 8. Avaliar a necessidade de apoio técnico especializado às Unidades Regionais de Saúde e municípios em situações que excedam sua capacidade de resposta. 9. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas
ATENÇÃO ESPECIALIZADA - REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1. Detalhar informações com comprovação das necessidades de infraestrutura dos serviços impactados pelo desastre ambiental bem como, manter a CASPD-DR e respectivas Unidades Regionais de Saúde atualizada da situação para acompanhamento do status assistencial até o retorno das atividades regulares; 2. Consolidar registros para avaliação posterior e prestação de contas.

Ações - Período de Seca e Estiagem

Estágio operacional de NORMALIDADE

QUADRO 10: Setores de atuação no estágio operacional de normalidade e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1. Análise Territorial e Mapeamento de Riscos: realizar territorialização e monitoramento contínuo do território e das microáreas, identificando bolsões de vulnerabilidade socioambiental (ilhas de calor, áreas de degradação do solo, desmatamento e proximidade de cinturões químicos ou rotas de cargas perigosas) e populações em situação de maior vulnerabilidade (quilombolas, indígenas, ciganos, populações rurais e assentados) assim como populações do campo, floresta e águas e povos e comunidades tradicionais e outros, a fim de mitigar iniquidades históricas de acesso e planejar serviços específicos; 2. Gestão de Sistemas e Comunicação: instituir o Protocolo de Comunicação de Risco integrado com outros pontos da Rede de Assistência à Saúde (RAS) definindo critérios operacionais (ex: produção de materiais educativos durante o período de normalidade e informativo urgente na emergencial) para evitar ruídos de comunicação e pânico. Padronizar formulários físicos de contingência para registro manual de dados, garantindo a continuidade da assistência caso a conectividade digital (e-SUS) seja interrompida pelo desastre; 3. Atualização Cadastral no e-SUS APS: manter os cadastros domiciliares e individuais atualizados, registrando obrigatoriamente a ocupação ou ramo produtivo do usuário, com reconhecimento do trabalho como determinante do processo saúde-doença, estratificar os grupos mais vulneráveis (idosos, crianças menores de 5 anos, gestantes, pessoas com doença renal crônica e portadores de patologias cardiorrespiratórias); 4. Gestão e Educação Permanente: fomentar, junto à gestão municipal, a completude das equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) com cumprimento integral da jornada de trabalho, e promover a educação permanente dos profissionais das equipes de APS e Saúde Bucal para o manejo de agravos relacionados à seca e à estiagem e para a identificação precoce de riscos; 5. Infraestrutura e Insumos: avaliar e fortalecer a capacidade de resposta das unidades de saúde, constituindo estoques estratégicos de insumos essenciais para o enfrentamento da seca e da estiagem no território; 6. Produção de Conhecimento Técnico: elaborar e divulgar materiais

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	informativos sobre a prevenção de doenças comuns em períodos de seca e estiagem, como hepatite A e Doenças Diarreicas Agudas, problemas respiratórios, desidratação e entre outras; 7. Busca Ativa e Monitoramento: realizar visitas domiciliares às famílias em situação de vulnerabilidade, conforme estratificação de risco, e monitorar o absenteísmo em consultas, procedimentos e dispensação de medicamentos. Recomenda-se a construção de uma planilha de monitoramento de indicadores de risco e assiduidade para identificar falhas na continuidade do cuidado no território; 8. Saúde do Trabalhador: realizar o mapeamento de trabalhadores expostos a riscos, qualificar o registro de dados ocupacionais na Ficha de Cadastro Individual e pactuar fluxos assistenciais intersetoriais. Além disso, articular o matriciamento com o CEREST para planejar ações de proteção, otimizando a capacidade de resposta a eventos de seca e estiagem; 9. Vigilância Epidemiológica e Imunização: monitorar os sistemas de informação para a detecção precoce de surtos e realizar busca ativa vacinal para atualização do calendário de rotina, reduzindo o risco de surtos em populações vulnerabilizadas; 10. Reservatórios e Vetores: integrar a atuação de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate de Endemias (ACE) na orientação das famílias sobre o manejo seguro da água (filtragem, fervura ou uso de hipoclorito), a limpeza e a vedação de caixas d'água e cisternas, e o controle de criadouros do <i>Aedes aegypti</i>; 11. Educação em Saúde e Programa Saúde na Escola (PSE): realizar orientações sobre o uso racional da água, a prevenção de incêndios e os riscos do calor extremo, integrando ao PSE ações sobre saúde ambiental, qualidade da água, poluição, mudanças climáticas e atualização vacinal dos estudantes, de modo a fortalecer os espaços de discussão sobre mudanças climáticas e saúde ambiental nas escolas; 12. Qualificação Comunitária e Fortalecimento da Resiliência Territorial: qualificar os atores comunitários sobre os riscos climáticos e o uso racional da água, promovendo a educação para a cidadania antes do período crítico e preparando uma atuação integrada e resolutiva que fortaleça a resiliência comunitária e a autonomia dos territórios no enfrentamento preventivo aos desafios da seca e da estiagem; 13. Articulação Intersetorial: estabelecer interface com órgãos de abastecimento de água, Defesa Civil, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	modo que o fluxo de informações técnicas (potabilidade e interrupções no abastecimento) seja traduzido pela APS em orientações preventivas para a população; 14.Biossegurança: assegurar o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS) nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) em conformidade com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) ANVISA nº 222/2018 e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 358/2005; 15.Comunicação de risco: articular com a Assessoria de Comunicação Social ASCOM ou órgão municipal oficial o estabelecimento de fluxos para a criação de materiais informativos sobre a prevenção de agravos decorrentes da seca e estiagem, qualificando as equipes da APS e Saúde Bucal para orientar junto ao território, utilizando os canais de comunicação oficiais; 16.Controle social: incentivar a participação ativa de lideranças e redes de apoio nos Conselhos de Saúde para o mapeamento colaborativo de riscos, fortalecendo a governança compartilhada com conselho de saúde no enfrentamento dos impactos da seca e estiagem; 17.Monitorar e analisar periodicamente o banco de notificações de casos suspeitos e/ou confirmados de febre maculosa Brasileira e arboviroses; acompanhar e divulgar orientações para o tratamento, vigilância laboratorial, investigação ambiental e epidemiológica oportuna; elaborar material técnico/informativo para orientação e atualização sobre vigilância, clínica, tratamento, prevenção e controle; 18.Realizar monitoramento sistemático e análise periódica dos dados epidemiológicos relacionados às Doenças Diarreicas Agudas (DDA), Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) e demais agravos sensíveis às alterações da qualidade da água e alimentos, visando à identificação precoce de mudanças no padrão epidemiológico; 19.Manter vigilância ativa baseada em indicadores e eventos, incluindo monitoramento de rumores, notificações, surtos e eventos de relevância em saúde pública relacionados à transmissão hídrica e alimentar; 20.Elaborar, atualizar e divulgar notas técnicas, informes epidemiológicos, protocolos, fluxos operacionais e materiais orientadores sobre vigilância, prevenção, investigação e resposta às DDA e DTHA; 21.Promover capacitações, treinamentos e reuniões técnicas periódicas para profissionais da vigilância epidemiológica, assistência e atenção primária, com

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	foco na detecção precoce, notificação, investigação e encerramento oportuno de casos e surtos; 22.Fortalecer a utilização e a qualidade dos sistemas de informação em saúde, especialmente o SIVEP-DDA, SINAN e demais sistemas relacionados ao monitoramento de surtos e eventos de transmissão hídrica e alimentar; 23.Avaliar periodicamente a capacidade diagnóstica e de suporte laboratorial para investigação de surtos e casos de DTHA e DDA, articulando apoio técnico quando necessário; 24.Produzir análises de situação de saúde e caracterização do perfil epidemiológico dos territórios prioritários, identificando populações vulneráveis, áreas de risco e fatores condicionantes associados à ocorrência de doenças de transmissão hídrica e alimentar; 25.Estabelecer fluxos de comunicação e articulação permanentes entre Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde Ambiental, CIEVS, Atenção Primária à Saúde, Laboratórios de Saúde Pública e Secretarias Municipais de Saúde para preparação e resposta oportuna a potenciais emergências em saúde pública; 26.Apoiar a elaboração e atualização de planos de contingência, protocolos de resposta e instrumentos de preparação para enfrentamento de surtos e emergências relacionadas à escassez hídrica, contaminação da água para consumo humano e eventos ambientais extremos; 27.Monitorar casos e óbitos por Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Grave (SRAG) no território Estadual; 28.Promover estratégias de capacitação para os profissionais de saúde; 29.Identificar casos de SG e realizar testagem para covid-19 (TR-antígeno); 30.Orientar quanto as ações de prevenção a transmissão; 31.Fortalecer a coleta de amostras de RT PCR para covid-19, influenza e outros vírus respiratórios em todo caso de SRAG Hospitalizado ou óbito por SRAG garantindo investigação ampliada de vírus respiratórios.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1.Realizar a identificação de municípios prioritários, conforme vulnerabilidades e série histórica; 2.Atualizar o Plano de Contingência Estadual para Seca/estiagem; 3.Realizar webnário e capacitações para as Secretarias Municipais de Saúde; 4.Elaborar material de divulgação para ações de educação em saúde; 5.Definir profissional como ponto focal para as ações de enfrentamento do período de seca e estiagem; 6.Apoiar URS e respectivos municípios na construção dos Planos de Contingência Municipais para Emergências em Saúde Pública por seca e estiagem; 7.Apoiar o monitoramento de dados de controle e vigilância executado pelos municípios; 8.Monitorar o SISAGUA por meio de relatórios disponibilizados; 9.Capacitar profissionais de saúde para atuação na investigação de surtos de DTHA/DDA, no que tange as competências do Programa Vigiaqua; 10.Realizar reuniões de sensibilização sobre o período de seca e estiagem; 11.Fomentar o aumento do percentual de cadastro das formas de abastecimento de água para consumo humano no SISAGUA - Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano; 12.Analisar dados de controle e vigilância e realizar diagnóstico da qualidade da água; 13.Manter articulação junto a CELP e ao LACEN/FUNED para o planejamento anual da cota de insumos para realização de análises de água que subsidiam as investigações epidemiológicas de surtos de DTHA/DDA e situações de emergência; 14.Fomentar e apoiar a realização de inspeções sanitárias preventivas em formas de abastecimento de água conforme preconizado pela Portaria 888/2021; 15.Realizar o planejamento anual junto ao Ministério da Saúde do insumo hipoclorito de sódio 2,5% para garantir a sua disponibilidade em momento

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	oportuno; 16.Fomentar a fortalecer a articulação intersetorial com órgãos e instituições que atuam direta ou indiretamente com o fornecimento de água para consumo humano, como órgãos ambientais, Ministério da Saúde, Agências Reguladoras de serviços de saneamento básico, prestadores de serviço, vigilância sanitárias, dentre outros;
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	1.Apoiar com diretrizes e orientações a elaboração da análise da situação de saúde dos trabalhadores, considerando os determinantes e condicionantes relacionados aos processos produtivos e às condições ambientais; 2.Monitorar o planejamento e execução das ações voltadas à proteção da saúde dos trabalhadores envolvidos nas atividades produtivas possivelmente afetadas; 3.Apoiar no rastreamento de atividades econômicas e de grupos ocupacionais com maior exposição ao risco, 4.Desenvolver ações de educação permanente e comunicação de risco direcionadas a trabalhadores, empregadores e equipes de saúde, com foco na prevenção de doenças e agravos relacionados às condições de trabalho; 5.Desenvolver ações de matriciamento junto a APS e rede de urgência e emergência, para a adequada identificação do usuário como trabalhador, nos sistemas de informação de saúde, para a identificação de agravos e doenças, com ênfase nos eventos associados à exposição ao calor, à desidratação, à inalação de poeiras e fumaças e a outros fatores ambientais adversos; 6.Apoiar a identificação de municípios silenciosos para notificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho, bem como as lacunas na capacidade instalada promovendo a inserção da temática nas instâncias de controle social; 7.Fortalecer a articulação intersetorial com órgãos de meio ambiente, defesa civil, saneamento e setores produtivos, visando à atuação integrada frente aos fatores de risco relacionados à estiagem; 8.Apoiar e instrumentalizar a realização de inspeções sanitárias nos ambientes e processos de trabalho de maior risco.

SETOR	AÇÕES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1. Garantir acesso aos medicamentos e insumos, conforme Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e perfil epidemiológico de cada território; 2. Apoiar a vigilância em saúde ambiental no suprimento de hipoclorito de sódio a 2,5% para desinfecção da água para consumo humano; 3. Integrar-se às ações de preparação para emergências relacionadas à seca e estiagem (Minas Gerais, 2025).
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	1. Divulgar para as secretarias municipais de saúde material educativo digital para reprodução e uso em situações de emergência em saúde pública por seca e estiagem; 2. Divulgar materiais educativos no sítio eletrônico da SES/MG – Portal da Vigilância.

SETOR	AÇÕES
CIEVS	1.Manter a rotina habitual de detecção, triagem e verificação de rumores, por meio de mineração de dados contínua e sistemática de fontes oficiais e não oficiais para detecção precoce de eventos; 2.Manter a rotina de interlocução com os Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE)/ Rede Renaveh; 3.Articular com o CIEVS Nacional e outras instâncias da Rede CIEVS a troca de informações estratégicas sobre sinais, eventos e medidas de resposta; 4.Realizar capacitações para os NHE sobre elaboração de Planos de Contingência Hospitalares; 5.Manter regime de plantão permanente (inclusive em fins de semana e feriados), garantindo o recebimento e análise oportuna de notificações de eventos, com pronta resposta a qualquer sinal de emergência em saúde pública; 6.Manter vigilância baseada em eventos, incluindo monitoramento de rumores, notificações, surtos e eventos de relevância em saúde pública relacionados à transmissão hídrica, alimentar, síndrome gripal/ síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, zoonóticas e outros agravos de relevância para saúde pública; 7.Manter fluxos de comunicação e articulação permanentes entre Vigilância Epidemiológica, Imunização, Vigilância em Saúde Ambiental, Atenção Primária à Saúde, Atenção Hospitalar, Rede de Urgência e Emergência, Laboratórios de Saúde Pública e Regulação do acesso aos serviços de saúde para preparação e resposta oportuna a potenciais emergências em saúde pública; 8.Apoiar a elaboração e atualização de planos de contingência, protocolos de resposta e instrumentos de preparação para enfrentamento de surtos e emergências relacionadas à escassez hídrica, contaminação da água para consumo humano, aumento de agravos respiratórios, sobrecarga do sistema ou desassistência e eventos ambientais extremos; 9.Promover reuniões ordinárias do Comitê de Monitoramento de Eventos (CME) para acompanhamento dos eventos e análise de risco.

Estágio operacional de MOBILIZAÇÃO

QUADRO 11: Setores de atuação no estágio operacional de mobilização e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.Intensificação da Busca Ativa: realizar visitas domiciliares a usuários e famílias em situação de vulnerabilidade, utilizando protocolos de estratificação de risco e monitorar o absenteísmo em consultas, procedimentos e dispensação de medicamentos, com ênfase em grupos prioritários (gestantes, idosos e pessoas com doença renal crônica) e populações de campo, floresta e águas e povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ciganos, populações rurais, assentados e outros para prevenir a desassistência antes de agravamentos do cenário da seca e estiagem; 2.Monitoramento Qualificado de Reservatórios e Vetores: fomentar a ação integrada entre ACS e ACE para otimizar o diagnóstico territorial, unindo a vigilância de riscos ambientais e vetoriais ao acompanhamento das famílias, garantindo orientações e ações coordenadas da APS e Vigilância em Saúde; 3.Acolhimento e Manejo de Sintomas cardiorespiratórios: adequar as agendas e fluxos nas UAPS, otimizando o atendimento frente ao aumento esperado de sintomas cardiorespiratórios decorrentes da seca. Intensificar a estratificação de risco dos trabalhadores expostos a poluentes ou substâncias químicas e qualificar a equipe para identificar precocemente os agravos antes da instalação crítica do evento climático; 4.Rastreamento Ocupacional e Matriciamento: implementar o matriciamento junto ao CEREST para identificar e monitorar trabalhadores expostos a riscos ocupacionais a céu aberto ou a agentes poluentes, considerando sua maior suscetibilidade aos impactos do período de seca e estiagem, antecipando medidas para evitar o agravamento da saúde dos trabalhadores;

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	5. Articulação Intersetorial: estabelecer interlocução com serviços de tratamento de água e órgãos de saneamento para monitorar indicadores de potabilidade, riscos de contaminação nos mananciais e interrupções no fornecimento, emitindo relatórios de alerta preventivos no território adscrito; 6. Redes de Apoio Comunitário: mobilizar lideranças locais, associações e voluntários para colaborar no mapeamento de áreas com risco iminente de escassez hídrica, fortalecendo a resposta comunitária diante do agravamento do cenário; 7. Comunicação de Risco Proativa antecipar a comunicação e as orientações preventivas à população sobre o uso racional da água, os perigos de mananciais impróprios, os riscos do calor extremo e a prevenção de incêndios; 8. Fortalecimento do Controle Social: fomentar e implementar, por meio das Unidades Regionais de Saúde (URS), a articulação estratégica com os Conselhos de Saúde. Incentivando o Controle Social a participar ativamente do monitoramento das ações e serviços, a validar as estratégias territoriais de enfrentamento à seca e à estiagem, e a fortalecer a resposta comunitária e a autonomia dos territórios diante do agravamento do cenário; 9. Armazenagem da água: intensificar orientações junto a população do território sobre o uso racional e o armazenamento da água em conformidade com os protocolos da Saúde Ambiental visando o engajamento da comunidade antes da instalação do cenário críticos; 10. Reorganização de Fluxos Internos: realizar a revisão dos fluxos internos e processos assistenciais das UAPS frente ao cenário de risco, visando otimizar a capacidade de resposta durante a instalação de cenários críticos de eventos climáticos, qualificando equipe para o manejo adequado dos agravos esperados.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	1.Intensificar o monitoramento epidemiológico das Doenças Diarreicas Agudas (DDA) por meio da análise sistemática dos registros no SIVEP-DDA, visando à identificação precoce de alterações no comportamento epidemiológico dos casos e à detecção de potenciais surtos; 2.Reforçar a vigilância epidemiológica das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA), com monitoramento contínuo de notificações, rumores, eventos e agravos potencialmente relacionados à deterioração da qualidade da água para consumo humano e dos alimentos; 3.Intensificar a análise de indicadores epidemiológicos sensíveis aos impactos da seca e estiagem, incluindo DDA, DTHA, hepatite A e outros agravos associados à escassez hídrica e às condições sanitárias inadequadas; 4.Fortalecer a vigilância baseada em eventos, em articulação com o CIEVS, para identificação, validação e acompanhamento oportuno de rumores e sinais de alerta relacionados à ocorrência de surtos de transmissão hídrica e alimentar; 5.Realizar avaliação periódica da situação epidemiológica dos municípios sob maior risco, identificando áreas prioritárias, populações vulneráveis e possíveis fatores de exposição associados à ocorrência de agravos; 6.Intensificar ações de orientação técnica e apoio institucional às Unidades Regionais de Saúde e municípios quanto aos fluxos de notificação, investigação, monitoramento e resposta a surtos de DDA e DTHA; 7.Atualizar e divulgar informes epidemiológicos, notas técnicas, alertas e recomendações para subsidiar a tomada de decisão e a preparação dos serviços de saúde para eventual agravamento do cenário; 8.Avaliar a capacidade operacional da rede de vigilância epidemiológica e laboratorial para resposta oportuna a eventos de saúde pública relacionados à transmissão hídrica e alimentar; 9.Promover capacitações direcionadas aos profissionais de vigilância e assistência, com foco na detecção precoce, investigação e manejo de surtos de DDA e DTHA em contextos de escassez hídrica e emergências ambientais; 10.Monitorar casos e óbitos por Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Grave (SRAG) no território Estadual;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	11.Promover estratégias de capacitação para os profissionais de saúde; 12.Identificar casos de SG e realizar testagem para covid-19 (TR-antígeno); 13.Orientar quanto as ações de prevenção a transmissão; 14.Fortalecer a coleta de amostras de RT PCR para covid-19, influenza e outros vírus respiratórios em todo caso de SRAG Hospitalizado ou óbito por SRAG garantindo investigação ampliada de vírus respiratórios; 15.Identificar municípios e populações vulneráveis com maior risco de interrupção do acesso aos serviços de vacinação; 16.Reforçar junto aos municípios a importância da manutenção da vacinação de rotina e das estratégias de busca ativa de não vacinados; 17.Preparar estratégias de vacinação extramuros para eventual necessidade de atendimento a populações com dificuldade de acesso aos serviços de saúde.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1.Realizar o monitoramento de alertas climáticos junto aos órgãos estaduais e federais de meteorologia; 2.Realizar o monitoramento de decretos de situação de emergência junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 3.Articular atuação conjunta com outros órgãos do Estado; 4.Articular atuação conjunta entre as áreas da SES; 5.Apoiar o monitoramento intensificado da qualidade da água para consumo humano; 6.Articular junto à CELP e LACEN/FUNED a realização de análises de água foram do planejamento de rotina; 7.Avaliar junto às Regionais de Saúde e municípios os estoques de hipoclorito de sódio a 2,5% e garantir a disponibilidade do estoque do nível central para suprir possível aumento de demanda;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	8.Acompanhar informações relacionadas à intermitência ou precariedade do abastecimento de água; intensificar ações educativas junto às comunidades; 9.Reforçar o apoio técnico às Regionais de Saúde e aos municípios para preparação e resposta o que tange às ações do Programa Vigiagua.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	1.Planejar, conjuntamente com outras áreas da vigilância, ações voltadas à proteção da saúde dos trabalhadores expostos; 2.Promover ações de educação em saúde e emitir comunicação de risco e recomendações de medidas de proteção e promoção direcionadas a trabalhadores, empregadores e equipes de saúde, com orientações sobre prevenção de doenças e agravos relacionadas às exposições de risco nos ambientes e processos de trabalho mais afetados pela seca e estiagem; 3.Apoiar o direcionamento, nos territórios afetados, de ações preventivas relacionadas à exposição aos incêndios florestais; 4.Intensificar o rastreamento e o monitoramento de grupos ocupacionais mais vulneráveis, especialmente em atividades a céu aberto, como agricultura, construção civil, limpeza urbana e outras expostas a condições climáticas adversas; 5.Fortalecer a articulação intersetorial com órgãos de meio ambiente, defesa civil, agricultura e setores produtivos, visando à atuação integrada frente aos riscos relacionados à estiagem;
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.Verificar a capacidade da assistência farmacêutica a população atingida; 2.Apoiar as unidades atingidas no remanejamento de medicamentos e insumos, se necessário.
SETOR	AÇÕES
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASCOM	1.Divulgar para o nível regional das secretarias de saúde material educativo para reprodução local e uso em situações de emergência em saúde pública por seca e estiagem;

SETOR	AÇÕES
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASCOM	2.Divulgar, no âmbito municipal, boletim informativo de comunicação de risco de seca e estiagem ou de alerta para os surtos de doenças decorrentes das condições de seca.
SETOR	AÇÕES
CIEVS	1.Instaurar CME semanal para monitoramento dos eventos; 2.Elaborar, em conjunto com áreas técnicas, alertas epidemiológicos para Unidades Regionais de Saúde (URS) e Secretarias Municipais de Saúde (SMS); 3.Fortalecer a vigilância baseada em eventos, para identificação, validação e acompanhamento oportuno de rumores e sinais de alerta relacionados à ocorrência de surtos de transmissão hídrica e alimentar, leptospirose, hepatite A, doenças respiratórias ou outros agravos relacionados ao evento seca/ estiagem; 4.Monitorar a expedição de decretos de situação de emergência pelos Municípios junto a Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental.

Estágio operacional de ALERTA

QUADRO 12: Setores de atuação no estágio operacional de alerta e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.Gestão de Insumos e Logística: realizar avaliação sistemática da disponibilidade e suficiência de estoques estratégicos, incluindo hipoclorito de sódio, sais de reidratação oral (SRO) e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), otimizando a reposição para assegurar a continuidade da assistência e a capacidade de resposta imediata da APS no território; 2.Monitoramento de Reservatórios e Vetores: intensificar, junto aos ACS e ACE, a vigilância de reservatórios domiciliares (caixas d'água, cisternas, tonéis) diante do aumento do armazenamento de água pelas famílias, reforçando orientações sobre vedação adequada e controle de criadouros do Aedes aegypti, em articulação com a Vigilância Ambiental; 3.Vigilância, Monitoramento e Ferramentas Digitais: ampliar a vigilância de sentinela para síndromes gripais, doenças diarreicas e desidratação, utilizando o e-SUS APS e e-SUS Território para o registro de dados, realizando testes de conectividade dos sistemas digitais. Aplicar a Triagem para Risco de Insegurança Alimentar (TRIA) para manter a base de dados atualizada e subsidiar a busca ativa; 4.Monitoramento de Vulneráveis, Vacinação e Busca Ativa: monitorar as condições de saúde das populações vulneráveis, especialmente em áreas de difícil acesso. Realizar busca ativa para a atualização do cartão de vacinação, priorizando grupos de maior risco (crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas), antecipando a proteção contra doenças imunopreveníveis antes do agravamento do período crítico da seca e estiagem. Atualizar os cadastros individuais e familiares no e-SUS APS para facilitar o planejamento das ações da fase seguinte; Ações Assistenciais, Educativas e Manejo Clínico: 5.Manejo Clínico: avaliar a capacidade de atendimento local para diagnosticar, tratar e acompanhar os agravos decorrentes da seca, conforme os protocolos vigentes, priorizando o monitoramento clínico de quadros iniciais de desidratação (letargia, câibras e fraqueza) e o manejo de dermatoses e patologias respiratórias associadas à exposição a poluentes ou cinzas;

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.Hidratação: qualificar as equipes de APS e Saúde Bucal para a identificação precoce de sinais de desidratação e fortalecer as ações de hidratação e reidratação oral nas UAPS e nos domicílios; 7.Educação em Saúde: Intensificar as ações educativas sobre o manuseio, a filtragem e o armazenamento adequado da água, reduzindo os riscos de contaminação; 8.Articulação da Rede (RAS) e Fluxos de Atendimento: apoiar as URS na organização de fluxos operacionais integrados, garantindo o compartilhamento seguro do cuidado entre os pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) em casos de desidratação grave e ou intoxicação ocasionados pelo evento climático, incluindo a assistência psicossocial; 9.Comunicação de Risco: apoiar as URS na implementação de fluxos transparentes de informação entre o setor saúde, a população e a imprensa. Os comunicados oficiais devem ser objetivos e coordenados para evitar desinformação e pânico, especialmente em zonas de insegurança alimentar ou escassez hídrica, e deve-se manter contato diário com Defesa Civil e o órgão de Meio Ambiente; 10.Fortalecimento controle Social: promover reuniões de alinhamento com os Conselhos de Saúde para antecipar os riscos climáticos e capacitar o Controle Social para auxiliar as equipes na logística de busca ativa e no suporte domiciliar, estabelecendo canais diretos de mediação entre as demandas da comunidade e os serviços de saúde.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	1.Intensificar o monitoramento epidemiológico das Doenças Diarreicas Agudas (DDA) e das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA), com análise diária dos sistemas de informação e identificação precoce de alterações no comportamento epidemiológico dos agravos; 2.Notificar imediatamente ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) os surtos, eventos e situações de risco relacionados às DDA e DTHA, conforme protocolos vigentes, bem como assegurar o registro oportuno nos sistemas oficiais de informação; 3.Realizar investigação epidemiológica integrada e oportuna dos surtos, em articulação com Vigilância em Saúde Ambiental, Laboratório de Saúde Pública, Atenção Primária à Saúde e demais áreas envolvidas, visando identificar fontes de exposição, fatores de risco e medidas de controle; 4.Fortalecer a vigilância baseada em eventos e o monitoramento de rumores, sinais e alertas relacionados à ocorrência de doenças de veiculação hídrica e alimentar, em articulação com o CIEVS e as Unidades Regionais de Saúde; 5.Avaliar continuamente a evolução epidemiológica dos municípios sob maior risco, monitorando tendências, distribuição espacial dos casos, grupos populacionais vulneráveis e potenciais impactos à saúde pública; 6.Produzir e divulgar informes epidemiológicos semanais, alertas e análises situacionais contendo informações sobre DDA, DTHA e outros agravos sensíveis à seca e estiagem, subsidiando a tomada de decisão pelos gestores e equipes de resposta; 7.Apoiar tecnicamente os municípios na adoção de medidas de prevenção, controle e mitigação, incluindo a implementação de ações oportunas frente à identificação de surtos ou aumento incomum de casos; 8.Manter articulação permanente com as áreas de Vigilância em Saúde Ambiental, Atenção Primária, CIEVS e Laboratório de Saúde Pública para compartilhamento de informações, definição de estratégias de resposta e acompanhamento dos eventos em monitoramento;

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	9. Avaliar continuamente a necessidade de escalonamento das ações e de acionamento de estruturas de resposta ampliada, conforme a evolução do cenário epidemiológico; 10. Monitorar casos e óbitos por Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Grave (SRAG) no território Estadual; 11. Promover estratégias de capacitação para os profissionais de saúde; 12. Identificar casos de SG e realizar testagem para covid-19 (TR-antígeno); 13. Orientar quanto as ações de prevenção a transmissão; 14. Orientar etiqueta respiratória em locais de aglomeração (abrigos, alojamentos, etc); 15. Fortalecer a coleta de amostras de RT PCR para covid-19, influenza e outros vírus respiratórios em todo caso de SRAG Hospitalizado ou óbito por SRAG garantindo investigação ampliada de vírus respiratórios; 16. Disponibilizar acesso a vacinas contra influenza, covid-19 e VSR ao público alvo afetado; 17. Monitorar ocorrências de interrupção do fornecimento de energia elétrica e seus possíveis impactos na conservação dos imunobiológicos; 18. Reforçar a vacinação de rotina, com foco em grupos prioritários e populações vulneráveis; 19. Orientar os municípios para adoção de estratégias de vacinação extramuros quando houver dificuldade de acesso aos serviços de saúde; 20. Intensificar a busca ativa de indivíduos com esquemas vacinais incompletos.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1.Realizar o monitoramento de alertas climáticos junto aos órgãos estaduais e federais de meteorologia; 2.Realizar o monitoramento de decretos de situação de emergência junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 3.Manter articulação permanente com demais áreas da SES, com foco no monitoramento da situação de saúde relacionada às doenças e agravos mais comuns decorrentes da seca/estiagem; 4.Monitorar focos de queimas e índices de qualidade do ar; 5.Intensificar o monitoramento dos dados das soluções alternativas de abastecimento no Sisagua; 6.Orientar a utilização de veículos transportadores de água (caminhão-pipa) nas ações de vigilância por parte dos municípios afetados, assim como a distribuição de água engarrafada quando for caso; 7.Intensificar o apoio na investigação epidemiológica de surtos de DTHA e DDA, quando o veículo suspeito for a água para consumo humano; 8.Intensificar a articulação com a CELP e FUNED para a realização

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	oportuna de análises de água; 9.Divulgar e distribuir materiais para ações de educação em saúde; 10.Orientar e apoiar, quando necessário, a realização de inspeção em formas de abastecimento de água, inclusive de carro-pipa; 11.Orientar e monitorar a inserção de dados no SISAGUA por parte dos municípios e prestadores de serviço de abastecimento de água, quando for o caso; 12.Estabelecer articulação com atores estratégicos para viabilizar ações conjuntas de mitigação e resposta à seca e estiagem; 13.Apoiar processos de interlocução e comunicação de risco direcionados às populações vulnerabilizadas, com foco na promoção da equidade de saúde; 14.populações vulnerabilizadas, com foco na promoção da equidade em saúde; 15. Monitorar de forma sistemática a situação meteorológica e hidrológica; 16.Acompanhando os cenários previstos e os impactos potenciais na saúde, com base nos indicadores; 17.Recomendar a distribuição e o uso de hipoclorito de sódio 2,5% de forma imediata, com as devidas orientações de uso (material de apoio – cartilhas); 18.Articular com o CIEVS-MG para apoiar a resposta a potenciais ESP relacionados à seca e estiagem.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	1. Emitir comunicação de risco em nível local com orientações específicas voltadas à proteção da saúde dos trabalhadores expostos aos efeitos da estiagem; 2. Executar ações de prevenção, promoção e proteção à saúde dos trabalhadores expostos nos ambientes e processos de trabalho; priorizando grupos ocupacionais e atividades econômicas mais vulneráveis; 3. Monitorar a ocorrência e tendência de doenças e agravos relacionados ao trabalho, com ênfase nos eventos associados à exposição ao calor, à desidratação, à inalação de poeiras e fumaças e a outros fatores ambientais adversos; 4. Investigar e notificar doenças e agravos relacionados ao trabalho nos sistemas do SUS, promovendo a qualificação e a oportunidade dos registros; 5. Solicitar, se necessário, apoio técnico, para o CEREST Regional (para municípios da área de abrangência de CEREST), para a assistência especializada em saúde do trabalhador e para as ações de vigilância; 6. Apoiar e, quando necessário, executar inspeções sanitárias em ambientes e processos de trabalho com maior risco, visando à adoção de medidas imediatas de controle e mitigação; 7. Fortalecer a articulação intersetorial com órgãos de defesa civil, meio ambiente, saneamento e setores produtivos, para resposta coordenada aos impactos da estiagem sobre a saúde dos trabalhadores.
SETOR	AÇÕES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1. Acompanhar indicadores de incidência e prevalência de doenças; 2. Apoiar ações emergenciais para garantia de acesso a medicamentos e insumos essenciais (MINAS GERAIS, 2025).

SETOR	AÇÕES
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASCOM	1. Articular com as unidades regionais de saúde a distribuição de materiais educativos para os municípios; 2. Divulgar no âmbito central e municipal boletins informativos sobre os eventos em monitoramento; 3. Subsidiar o atendimento às demandas de imprensa, quando necessário.
SETOR	AÇÕES
GESTÃO SES	Intensificar a articulação com as SES para o desenvolvimento das ações de saúde estabelecidas no Plano de Contingência Estadual para Seca e Estiagem.
SETOR	AÇÕES
CIEVS	1. Instaurar sala de situação, coordenando as reuniões intersectoriais com SubVS e as outras áreas da SES/MG, com reuniões semanais; 2. Divulgação de boletins especiais com análise de risco e recomendações; 3. Avaliação do evento segundo o Regulamento Sanitário Internacional (RSI); 4. Avaliar os cenários de risco e recomendar medidas de preparação e resposta, incluindo a ativação de Centros de Operações de Emergência (COE).

Estágio operacional de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

QUADRO 13: Setores de atuação no estágio operacional de situação de emergência e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1. COE: participar e colaborar na execução das rotinas do Centro de Operações de Emergências (COE) municipal/regional, fortalecendo o alinhamento das decisões. 2. Inteligência de Dados via e-SUS Território: fomentar a sincronização diária e prioritária de dados por meio de dispositivos móveis, garantindo que o registro de sintomas migre para o Prontuário Eletrônico (PEC) e seja consolidado no sistema de informações da Atenção Primária à Saúde (SIAPS). A integração desses registros à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) é estratégica para assegurar a visibilidade epidemiológica, permitindo a tomada de decisão. 3. Monitoramento Territorial: manter o acompanhamento contínuo da população afetada e, junto às gestões locais, realizar a vigilância constante das ações no território. 4. Rede Assistencial: participar e colaborar para a reorganização da rede assistencial, para ampliar a capacidade de atendimento e intensificar a resposta aos agravos relacionados à seca e à estiagem. 5. Implementação Eventos Clínicos: fomentar e intensificar a capacidade assistencial para acolhimento, triagem, estabilização e manejo clínico de quadros agudos ou crônicos agudizados, conforme protocolos assistências vigentes e os eixos a seguir: 6. Agravos Respiratórios: a inalação de poluentes de queimadas, fuligem e gases tóxicos causa inflamação aguda das vias aéreas, com risco elevado de pneumonias e de exacerbação de quadros de DPOC, asma e rinites. 7. Monitoramento contínuo de usuários com pneumopatias crônicas preexistentes; 8. Suporte inalatório na UAPS e orientação sobre o uso de respiradores para reduzir a exposição a partículas finas. 9. Complicações Cardiovasculares: o estresse térmico e a absorção de toxinas sobrecarregam o sistema circulatório e renal, podendo induzir arritmias, infarto e crises hipertensivas.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	10. Monitoramento da população com cardiopatias crônicas e de idosos expostos ao calor intenso; 11. Realizar o encaminhamento prioritário à média ou alta complexidade via protocolos assistenciais vigentes, garantindo o fluxo de referência imediato em casos de descompensação grave. 12. Desidratação e Agravos Renais: a perda excessiva de líquidos por transpiração, aliada à baixa umidade, provoca desequilíbrio hidroeletrolítico, letargia e risco de nefrolitíase e de insuficiência renal aguda. 13. Avaliação clínica sistemática de sinais de alerta (tontura, irritabilidade, confusão mental), especialmente em crianças e idosos; 14. Campanhas de orientação para o consumo frequente de água potável. 15. Doenças Gastrointestinais, Intoxicações e Risco Nutricional: riscos associados ao consumo de água contaminada por patógenos ou substâncias químicas e o consequente impacto na absorção de nutrientes, com ênfase no risco de desnutrição aguda infantil associada a episódios recorrentes de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA). 16. Estruturação de salas de reidratação oral nas UAPS para reduzir internações sensíveis à atenção primária; 17. Realizar a vigilância nutricional em menores de 5 anos, mediante o registro periódico da antropometria (peso e altura) no e-SUS APS. Essa ação visa identificar o déficit nutricional ou a desnutrição no cenário de desastre. O acompanhamento contínuo permitirá intervenções e o monitoramento da situação de saúde dessa população vulnerável; 18. Investigação de surtos de Doença Diarreica Aguda (DDA) e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA). 19. Busca ativa de casos de desidratação e desnutrição, e referenciar conforme protocolos assistenciais vigentes. 20. Dermatoses Ocupacionais e Clínicas: afecções cutâneas irritativas ou sensibilizantes decorrentes do contato com poluentes suspensos, cinzas quentes ou produtos químicos. Tratamento de lesões agudas e notificação compulsória no SINAN (Intoxicação Exógena ou Dermatose Ocupacional) e registro da relação causal com o

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	trabalho durante o atendimento. 21. Acidentes por Animais Peçonhentos: O deslocamento forçado da fauna silvestre devido aos incêndios e à seca aumenta a incidência de acidentes ofídicos e escorpiônicos nos territórios. 22. Intensificação de ações educativas comunitárias sobre prevenção; 23. Mapeamento de pontos estratégicos para dispensação de soros antivenenos e definição de fluxo de transferência para atendimento de urgência. 24. Busca Ativa de Vulneráveis: executar a busca ativa de indivíduos em situação de maior vulnerabilidade (idosos, crianças, gestantes, pessoas com deficiência, etc.). 25. Apoio Técnico à Gestão: articular e apoiar a gestão na orientação da população sobre fluxos de atendimento e horários de funcionamento, além de identificar cenários de risco em comunidades de difícil acesso (campo, floresta e ribeirinhas e outras). 26. Gestão de Imunobiológicos: para garantir a imunização em emergências, a APS deve manter estoques estratégicos de vacinas prioritárias em locais seguros, conforme Procedimento Operacional Padrão(POPs)de imunização vigentes e realizar ações itinerantes, priorizando busca ativa de esquemas incompletos em áreas críticas, a fim de mitigar riscos de surtos secundários. 27. Insumos e Equipamentos: otimizar a disponibilidade de kits emergenciais, incluindo itens de reidratação, suporte inalatório, máscaras proteção respiratória e insumos de higiene e medicamentos. A logística de reposição deve ser articulada de forma intersetorial, via COE, assegurando que o tempo entre a solicitação e a entrega às unidades seja compatível com a resposta tempestiva exigida pelos eventos de seca e estiagem no território. 28. Vigilância Ambiental: fomentar e colaborar no monitoramento da potabilidade da água, incluindo o abastecimento por caminhões-pipa e dos riscos químicos, atuando de forma intersetorial em casos de contaminação da água para prevenir eventos clínicos. 29. Vigilância Epidemiológica e CEREST: monitorar rotineiramente óbitos e atendimentos por diarreias, arboviroses, infecções respiratórias, em articulação com a rede de laboratórios (LACEN-MG/FUNED) e articular com o CEREST a proteção dos trabalhadores do território adscrito.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	30. Assistência Social (SUAS / CRAS / CREAS): integrar de forma intersetorial, o monitoramento das famílias em situação de extrema pobreza ou desabrigadas beneficiadas de programas sociais como o Bolsa Família ou BPC. 31. Articulação com Defesa Civil e Corpo de Bombeiros: atuar de forma intersetorial com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros no suporte assistencial ao território, otimizando o manejo clínico das vítimas em eventos de seca e estiagem e preservando a integração e o fluxo de resposta diante de cenários críticos.
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	1. Intensificar a investigação epidemiológica, o monitoramento e a adoção de medidas de controle dos surtos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA), garantindo resposta oportuna aos eventos de relevância para a saúde pública. 2. Realizar monitoramento sistemático e análise contínua dos indicadores de morbidade e mortalidade relacionados às DDA, DTHA e demais agravos associados à escassez hídrica e às condições sanitárias adversas. 3. Avaliar continuamente alterações no padrão epidemiológico dos casos, internações e óbitos, identificando tendências, áreas de maior risco, populações vulneráveis e possíveis eventos de transmissão coletiva. 4. Coordenar e apoiar investigações epidemiológicas integradas, em articulação com Vigilância em Saúde Ambiental, Laboratório de Saúde Pública, Atenção Primária à Saúde, CIEVS e demais áreas envolvidas na resposta à emergência. 5. Produzir análises epidemiológicas, informes técnicos e boletins periódicos para subsidiar a tomada de decisão dos gestores, das Salas de Situação e dos Centros de Operações de Emergência (COE). 6. Intensificar a vigilância baseada em eventos e o monitoramento de rumores relacionados à ocorrência de surtos de transmissão hídrica e alimentar, promovendo a verificação, avaliação de risco e resposta oportuna. 7. Apoiar tecnicamente as Unidades Regionais de Saúde e os municípios afetados na implementação de medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos à saúde da população. 8. Monitorar a oportunidade das notificações, investigações, coleta de amostras e encerramento dos surtos, visando garantir a qualidade das informações e a efetividade das ações de resposta.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	9. Participar das estruturas de gerenciamento da emergência, fornecendo informações epidemiológicas atualizadas para avaliação da situação de saúde, definição de prioridades e direcionamento das ações de enfrentamento. 10. Elaborar cenários epidemiológicos prospectivos e análises de risco para subsidiar o planejamento das ações de resposta e eventual escalonamento para níveis superiores de emergência. 11. Monitorar casos e óbitos por Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Grave (SRAG) no território Estadual. 12. Promover estratégias de capacitação para os profissionais de saúde. 13. Identificar casos de SG e realizar testagem para covid-19 (TR-antígeno). 14. Orientar quanto as ações de prevenção a transmissão. 15. Orientar etiqueta respiratória em locais de aglomeração (abrigos, alojamentos, etc). 16. Fortalecer a coleta de amostras de RT PCR para covid-19, influenza e outros vírus respiratórios em todo caso de SRAG Hospitalizado ou óbito por SRAG garantindo investigação ampliada de vírus respiratórios. 17. Disponibilizar acesso a vacinas contra influenza, covid-19 e VSR ao público-alvo afetado. 18. Articular com instituições parceiras o desenvolvimento das ações necessárias. 19. Priorizar a vacinação de grupos mais vulneráveis, especialmente crianças, gestantes, idosos e pessoas com condições de risco. 20. Implementar estratégias de vacinação extramuros em localidades com acesso comprometido. 21. Intensificar a busca ativa de indivíduos com esquemas vacinais atrasados ou incompletos.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1. Participar de comitês de emergência (salas de situação/COEs). 2. Realizar o monitoramento de decretos de situação de emergência junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 3. Manter articulação permanente com demais áreas da SES, com foco no monitoramento da situação de saúde relacionada às doenças e agravos mais comuns decorrentes da seca/estiagem. 4. Publicar boletim. 5. Intensificar a articulação com áreas da SES/MG e órgãos de Estado com ações relacionadas a estes desastres. 6. Monitorar colapso dos sistemas de abastecimento. 7. Recomendar a distribuição e o uso de hipoclorito de sódio 2,5% de forma imediata, com as devidas orientações de uso (material de apoio – cartilhas). 8. Articular com a SAF e Almoxarifado Central da SES a imediata disponibilização de hipoclorito de sódio 2,5% para o/os município/s afetado/s. 9. Intensificar o monitoramento dos dados das formas de abastecimento no Sisagua. 10. Orientar a utilização de veículos transportadores de água (caminhão-pipa) nas ações de vigilância por parte dos municípios afetados, assim como a distribuição de água engarrafada quando for caso. 11. Intensificar o apoio na investigação epidemiológica de surtos de DTHA e DDA, quando o veículo suspeito for a água para consumo humano. 12. Intensificar a articulação com a CELP e FUNED para a realização oportuna de análises de água. 13. Divulgar e distribuir materiais para ações de educação em saúde. 14. Divulgar e distribuir materiais para ações de orientação à população sobre tratamento intradomiciliar de água para consumo humano. 15. Orientar e apoiar, quando necessário, a realização de inspeção em formas de abastecimento de água, inclusive de carro-pipa.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	16. Orientar e monitorar a inserção de dados no SISAGUA por parte dos municípios e prestadores de serviço de abastecimento de água, quando for o caso. 17. Apoiar tecnicamente os municípios na implementação de ações de vigilância, mitigação e redução dos riscos à saúde em relação ao escopo do Vigiaqua. 18. Acompanhar notificações de seca e estiagem e reportar situação sanitária. Intensificação das ações descritas na etapa de alerta. 19. Articular com a Assessoria de Comunicação Social - Ascom a distribuição de materiais educativos para a população e os profissionais de saúde. 20. Articulação com Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS. 21. Apresentar no CME os eventos relacionados à seca e estiagem para apoiar na tomada de decisão. 22. Apoiar na interlocução e comunicação de risco das populações vulnerabilizadas à luz de garantir a equidade em saúde. 23. Monitorar de forma sistemática a situação meteorológica e hidrológica, acompanhando os cenários previstos e os impactos potenciais na saúde, com base nos indicadores.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	1. Participar de salas de situação e Centro de Operações de Emergências (COE), contribuindo com informações técnicas relacionadas à saúde do trabalhador. 2. Intensificar a vigilância das doenças e agravos relacionados ao trabalho, com monitoramento contínuo da ocorrência, distribuição e tendência dos eventos nos territórios afetados. 3. Apoiar ações emergenciais de proteção aos trabalhadores, especialmente aqueles envolvidos na resposta à crise, como equipes de abastecimento de água, limpeza urbana, saúde, defesa civil e outros serviços essenciais. 4. Solicitar, se necessário, apoio técnico, para o CEREST Regional (para municípios da área de abrangência de CEREST), para a assistência especializada em saúde do trabalhador e para as ações de vigilância.

SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	5. Recomendar e monitorar a adoção de medidas de proteção coletiva e individual nos ambientes e processos de trabalho, considerando os riscos agravados pela escassez hídrica e pelas condições sanitárias críticas. 6. Apoiar a realização de inspeções sanitárias em ambientes de trabalho prioritários, visando à mitigação imediata dos riscos à saúde dos trabalhadores. 7. Fortalecer a articulação intersectorial com órgãos de defesa civil, saneamento, meio ambiente e demais setores envolvidos na resposta à emergência. 8. Apoiar os serviços de saúde na identificação, manejo e notificação de agravos relacionados ao trabalho, assegurando a integração entre vigilância e assistência.
SETOR	AÇÕES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1. Participar de comitês de emergência; solicitar e apoiar a distribuição de kits de medicamentos e insumos estratégicos - PORTARIA GM/MS Nº 874, DE 4 DE MAIO DE 2021. 2. Apoiar logística de distribuição (MINAS GERAIS, 2025).
SETOR	AÇÕES
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	1. Articular com as secretarias municipais de saúde a distribuição de materiais educativos para a população e para os profissionais de saúde. 2. Divulgar boletins informativos sobre os eventos em monitoramento. 3. Subsidiar o atendimento às demandas de imprensa, quando necessário.
GESTÃO SES	1. Ativação no setor saúde do COE – Centro de Operações em parceria com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS.
SETOR	AÇÕES
GESTÃO SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1. Articular com os diretores e coordenadores das áreas de atuação para o atendimento oportuno à emergência. 2. Articular o envio de recursos adicionais (materiais e humanos) para o atendimento à emergência. 3. Acompanhar o desenvolvimento das ações de saúde estabelecidas no Plano de Contingência Estadual para Seca e Estiagem.

SETOR	AÇÕES
GESTÃO SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4. Apresentar a situação da emergência em saúde pública nas reuniões do Comitê de Monitoramento de Eventos - CME.

Estágio operacional de CRISE

QUADRO 09: Setores de atuação no estágio operacional de crise e suas ações.

SETOR	AÇÕES
ATENÇÃO PRIMÁRIA	1. COE: participar ativamente das rotinas do COE (municipal/regional) sob a lógica do Sistema de Comando de Operações. 2. Atuação Integrada de ACS e ACE: fomentar a integração entre Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) como eixo central da resposta, assegurando agilidade e efetividade no território durante situações de crise na seca e estiagem. A atuação conjunta deve promover apoio técnico, orientações domiciliares e ações intersetoriais, com foco na mitigação dos danos, na continuidade do cuidado e na redução dos impactos à saúde da população. 3. Inteligência de Dados (e-SUS Território): fomentar a sincronização diária e prioritária de dados por meio de dispositivos móveis, alimentando o sistema de inteligência epidemiológica do gabinete de crise. 4. Ciclo de Avaliação e Reabilitação: participar e colaborar nas reuniões de alinhamento técnico junto ao COE e na readequação das metas do plano de contingência, para subsidiar o restabelecimento da normalidade no território. 5. Regime Excepcional: reorganizar os serviços para atuar também em regime de plantão e com horários de atendimentos estendidos, priorizando a estabilização de quadros agudos e a implementação de diretrizes clínico-fisiopatológicas (manejo sintromico). 6. Busca Ativa e Grupos Prioritários: realizar busca ativa e monitorar pessoas em situação de maior vulnerabilidade (idosos, crianças, gestantes e pessoas com deficiência e outros usuários) com o objetivo de prevenir o agravamento e detectar precocemente sinais de desidratação e desnutrição e problemas respiratórios, mitigando o risco de hospitalizações na fase de crise em eventos de seca e estiagem. 7. Acompanhamento Continuado: manter o acompanhamento ininterrupto da população afetada e intensificar, em articulação com as URS, todas as ações já adotadas na etapa de emergência. 8. Gestão de Caso na RAS: Estratificar os riscos individuais para otimizar o uso de insumos, direcionando os pacientes graves para a rede de assistência à saúde de forma integrada e intersetorial. viabilizando o suporte do transporte sanitário para facilitar a continuidade da assistência. 9. Mobilização de Pontos de Apoio: operar pontos de apoio assistencial e reorientar as equipes da APS e Saúde Bucal para os locais de maior criticidade. 10. Assistência Farmacêutica: articular e implementar, de forma intersetorial, o

ATENÇÃO PRIMÁRIA	envio de insumos estratégicos (Kits de Calamidade) e antídotos regulados, conforme protocolos assistenciais. 11. Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): articular, de forma intersetorial, com SAD para o cuidado integral e intensivo de usuários acometidos por eventos climáticos relacionados à seca e à estiagem, priorizando acamados e pacientes crônicos complexos. Essa ação visa promover a desospitalização e reduzir o impacto de internações evitáveis, prevenindo hospitalizações desnecessárias. 12. Segurança da Cadeia de Frio: monitorar a temperatura de vacinas com termômetros digitais, assegurando a integridade e qualidade dos imunobiológicos. 13. Vacinação Itinerante: integrar a vacinação às equipes móveis, priorizando esquemas incompletos, principalmente em abrigos, para evitar surtos secundários no território. 14. Estoques Estratégicos: fomentar, de forma intersetorial a disponibilidade imediata de kits (reidratação, suporte inalatório, EPIs), com reposição automatizada e em tempo hábil, por meio do COE. 15. Vigilância Ambiental: monitorar a potabilidade da água e riscos químicos, atuando em conjunto com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. 16. Vigilância Epidemiológica e CEREST: monitorar em tempo real óbitos e agravos, integrando a rede de assistência à saúde e articulando com o CEREST às inspeções de segurança do trabalho. 17. Assistência Social: integrar o monitoramento da distribuição emergencial de kits a beneficiários de projetos sociais, como Bolsa Família e BPC, dentre outros. 18. Controle Social e Resposta Rápida: na fase de crise, os Conselhos de Saúde assumem papel protagonista e indispensável ao participar do COE; essa estratégia atua como um sensor territorial que confere legitimidade às intervenções e garante o acesso igualitário aos serviços de saúde no território. 19. Educação Popular em Saúde: mobilizar a comunidade para o uso racional da água e autocuidado, utilizando a lógica dialógica e canais de ouvidoria para relatos de desassistência. 20. Saúde Mental e Suporte aos Trabalhadores da APS em Situação de Crise: em cenários de crise, os profissionais da APS enfrentam sobrecarga física e emocional intensificada pela exaustão profissional, ocasionando riscos à saúde mental. Para garantir a continuidade do cuidado e a integridade da equipe adotar as seguintes estratégias: 20.1. Apoio Psicossocial Estruturado: fomentar e implementar de forma intersetorial ações de cuidado à saúde mental dos trabalhadores, com espaços de acolhimento e escuta qualificada, visando prevenir o esgotamento profissional (burnout). 20.2. Gestão do Cuidado e Prevenção de Violências: combater em parceria com RAS o estigma, o assédio e a violência (física ou moral) contra os trabalhadores durante a resposta, garantindo um ambiente de trabalho seguro e acolhedor.
--------------------------------	--

ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.3. Integração com a RAPS: elaborar em parceria com RAPS fluxos de referência prioritários para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), assegurando suporte aos profissionais que apresentarem sinais de sofrimento mental. 20.4. Gestão de Equipes: flexibilizar rotinas de trabalho e escalas para reduzir a exposição a riscos psicossociais, garantindo pausas de descanso e condições mínimas de trabalho, mesmo em contextos de escassez de recursos. 21. Articulação com a RAPS na Crise: 21.1. Acolhimento: realizar acolhimento e triagem no território em casos agudos de desorganização emocional e risco suicida. 21.2. Fluxo: fomentar implementar encaminhamentos para a RAPS, garantindo que usuários com quadros graves recebam assistência especializada. 21.3. Resposta integrada: estabelecer a articulação entre APS e RAPS viabilizando a continuidade do cuidado e mitigando os danos à saúde mental da população afetada.
SETOR	AÇÕES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1. Garantir acesso excepcional a medicamentos e insumos; apoiar logística emergencial. 2. Participar de comitês de emergência; solicitar e apoiar a distribuição de kits de medicamentos e insumos estratégicos - PORTARIA GM/MS Nº 874, DE 4 DE MAIO DE 2021. 3. Acompanhar prestação de contas e utilização dos insumos (MINAS GERAIS, 2025).
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	1. Realizar monitoramento epidemiológico contínuo e em tempo oportuno dos surtos, casos graves, internações e óbitos relacionados às Doenças Diarreicas Agudas (DDA), Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) e demais agravos associados à situação de crise. 2. Manter vigilância epidemiológica integrada e ampliada, com análise permanente da magnitude, distribuição, tendência e impacto dos agravos sobre a população afetada, identificando precocemente mudanças no perfil epidemiológico e situações de agravamento. 3. Instituir monitoramento específico dos casos de DDA e DTHA associados ao evento crítico, incluindo acompanhamento da evolução dos casos, hospitalizações, óbitos, grupos vulneráveis e áreas prioritárias para intervenção. 4. Intensificar a vigilância baseada em eventos, a detecção de surtos e o monitoramento de rumores, em articulação permanente com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), as Unidades

VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	Regionais de Saúde e os municípios afetados. 5. Coordenar e apoiar investigações epidemiológicas ampliadas para identificação de fatores determinantes, fontes de exposição e cadeias de transmissão, subsidiando a adoção imediata de medidas de controle e mitigação. 6. Produzir e divulgar boletins epidemiológicos, informes técnicos e análises situacionais em periodicidade compatível com a evolução da crise, subsidiando o Centro de Operações de Emergência (COE), as Salas de Situação e os gestores do SUS. 7. Apoiar a implementação de estratégias emergenciais de prevenção, controle e redução de danos, priorizando territórios de maior risco e populações em situação de vulnerabilidade. 8. Monitorar continuamente indicadores epidemiológicos críticos, incluindo incidência, hospitalizações, letalidade, ocorrência de surtos, dispersão geográfica dos casos e capacidade de resposta dos serviços de saúde. 9. Participar ativamente das estruturas de gestão da crise, fornecendo análises de risco, projeções epidemiológicas e recomendações técnicas para subsidiar a tomada de decisão e o direcionamento de recursos. 10. Avaliar continuamente a efetividade das medidas implementadas, revisando estratégias de vigilância e controle conforme a evolução do cenário epidemiológico e sanitário. 11. Monitorar casos e óbitos por Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Grave (SRAG) no território Estadual. 12. Promover estratégias de capacitação para os profissionais de saúde. 13. Identificar casos de SG e realizar testagem para covid-19 (TR-antígeno). 14. Orientar quanto as ações de prevenção a transmissão. 15. Orientar etiqueta respiratória em locais de aglomeração (abrigos, alojamentos, etc). 16. Fortalecer a coleta de amostras de RT PCR para covid-19, influenza e outros vírus respiratórios em todo caso de SRAG Hospitalizado ou óbito por SRAG garantindo investigação ampliada de vírus respiratórios. 17. Disponibilizar acesso a vacinas contra influenza, covid-19 e VSR ao público-alvo afetado. 18. Articular com instituições parceiras o desenvolvimento das ações necessárias. 19. Priorizar a manutenção da vacinação dos grupos mais vulneráveis e das
---	---

VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E IMUNIZAÇÃO	vacinas consideradas estratégicas para a prevenção de surtos. 20. Apoiar tecnicamente os municípios com interrupção parcial ou total das atividades de vacinação. 21. Implementar estratégias especiais de vacinação para populações afetadas, deslocadas ou com dificuldade de acesso aos serviços de saúde. 22. Articular junto às áreas de assistência, vigilância e gestão de emergências a priorização de recursos necessários à manutenção das ações de vacinação.
SETOR	AÇÕES
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	1. Atuar no monitoramento crítico dos sistemas de abastecimento. 2. Recomendar a distribuição e o uso de hipoclorito de sódio 2,5% de forma imediata, com as devidas orientações de uso (material de apoio – cartilhas). 3. Articular com a SAF e Almoxarifado Central da SES a imediata disponibilização de hipoclorito de sódio 2,5% para o/os município/s afetado/s. 4. Intensificar o monitoramento dos dados das formas de abastecimento no Sisagua. 5. Orientar a utilização de veículos transportadores de água (caminhão-pipa) nas ações de vigilância por parte dos municípios afetados, assim como a distribuição de água engarrafada quando for caso. 6. Intensificar o apoio na investigação epidemiológica de surtos de DTHA e DDA, quando o veículo suspeito for a água para consumo humano. 7. Intensificar a articulação com a CELP e FUNED para a realização oportuna de análises de água. 8. Divulgar e distribuir materiais para ações de educação em saúde. 9. Divulgar e distribuir materiais para ações de orientação à população sobre tratamento intradomiciliar de água para consumo humano. 10. Orientar e apoiar, quando necessário, a realização de inspeção em formas de abastecimento de água, inclusive de carro-pipa. 11. Orientar e monitorar a inserção de dados no SISAGUA por parte dos municípios e prestadores de serviço de abastecimento de água, quando for o caso. 12. Apoiar tecnicamente os municípios na implementação de ações de vigilância, mitigação e redução dos riscos à saúde em relação ao escopo do Vigiaqua.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	13. Acompanhar impactos ambientais ampliados. 14. Apoiar na interlocução e comunicação de risco das populações vulnerabilizadas a luz de garantir a equidade em saúde. 15. Monitorar de forma sistemática, junto aos parceiros, a situação meteorológica e hidrológica, acompanhando os cenários previstos e os impactos potenciais na saúde, com base nos indicadores. 16. Acompanhar notificações de seca e estiagem e reportar situação sanitária. 17. Intensificação das ações descritas na etapa de Situação de Emergência. 18. Articular com a Assessoria de Comunicação Social - Ascom a comunicação social para direcionar as ações de saúde. 19. Articulação com Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS.
SETOR	AÇÕES
GESTÃO SES	1. Informar as áreas e órgãos envolvidos na resposta à emergência a situação de saúde da região afetada e as ações de resposta desenvolvidas no âmbito da saúde.
SETOR	AÇÕES
GESTÃO SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1. Apresentar a situação da emergência em saúde pública nas reuniões do CME. 2. Articular, com o COEs, o envio de recursos adicionais (materiais e humanos) para o atendimento à crise. 3. Apoiar o COEs na resolução de conflitos e dificuldades encontradas na etapa de resposta. 4. Apoiar o COEs na articulação com a Coordenação da força estadual do SUS para o envio de equipe. 5. Avaliar a necessidade de recomendar ao nível federal a sugestão de declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) (Brasil, 2015).
SETOR	AÇÕES
SAÚDE DO TRABALHADOR	1. Monitorar continuamente os impactos severos à saúde dos trabalhadores, com análise da magnitude, distribuição e tendência das doenças e agravos relacionados ao trabalho. 2. Intensificar a vigilância das doenças e agravos relacionados ao trabalho, assegurando a detecção oportuna, investigação e notificação nos sistemas de informação do SUS.

SAÚDE DO TRABALHADOR	3. Solicitar, se necessário, apoio técnico, para o CEREST Regional (para municípios da área de abrangência de CEREST), para a assistência especializada em saúde do trabalhador e para as ações de vigilância. 4. Intensificar a realização das inspeções sanitárias em saúde do trabalhador nos ambientes e processos de trabalho prioritários, com foco na adoção imediata de medidas de controle e mitigação dos riscos. 5. Apoiar e executar ações emergenciais de proteção à saúde dos trabalhadores, especialmente aqueles envolvidos na resposta à crise e na manutenção de serviços essenciais. 6. Recomendar, implementar e monitorar medidas de proteção coletiva e individual, considerando os riscos extremos decorrentes da escassez hídrica e do colapso dos serviços. 7. Fortalecer a articulação intersetorial em nível ampliado (estadual e, quando necessário, federal), com órgãos de defesa civil, saneamento, meio ambiente e demais setores estratégicos.
SETOR	AÇÕES
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ASCOM	1. Acompanhar a distribuição de material informativo. 2. Divulgar notas informativas, conforme a necessidade identificada. 3. Subsidiar o COEs para o atendimento às demandas de imprensa, quando necessário.

4. ESTRUTURA, ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO COE

O Centro de Operações de Emergências (COE) configura-se como uma estratégia de gestão voltada para situações de emergência e eventos de saúde pública, permitindo a articulação de respostas coordenadas e oportunas entre diferentes setores; responsável pela articulação intersetorial, organização das ações e monitoramento contínuo do cenário epidemiológico e assistencial durante o desastre. Trata-se de uma estrutura temporária, cuja ativação ocorre em cenários que demandam resposta organizada a crises de saúde, mediante avaliação do Comitê de Monitoramento de Eventos (CME), e cuja desativação se dá após a resolução da situação, conforme definido por algoritmo de decisão e critérios técnicos estabelecidos pelos gestores estaduais de saúde.

O COE utiliza o Sistema de Comando de Operações (SCO) como ferramenta de gestão, o que possibilita a organização das ações de forma padronizada, com definição clara de funções, responsabilidades e fluxos de comunicação, favorecendo a tomada de decisão oportuna e a atuação integrada entre as áreas envolvidas.

A estrutura do COE será organizada de acordo com os princípios do SCO, contemplando, no mínimo, as funções de comando, planejamento, operações, logística e comunicação (Oliveira, 2010). Essa organização permite a atuação modular e escalável, podendo ser ampliada ou reduzida conforme a magnitude do evento e a complexidade da resposta necessária.

A composição do COE é formada por representantes de diversos setores da saúde, diretamente envolvidos nas ações de vigilância e resposta às emergências, além de especialistas nas áreas pertinentes ao evento em questão.

No âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o COE será composto por representantes das áreas técnicas estratégicas, incluindo, vigilância em saúde, CIEVS-MG, atenção à saúde, assistência farmacêutica, saúde ambiental, comunicação social e gestão, além de manter articulação permanente com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), Corpo de Bombeiros e demais órgãos e instituições parceiras. Essa composição visa garantir a abordagem intersetorial e a integração das ações, considerando os múltiplos impactos da seca e estiagem sobre a saúde da população.

A ativação da estrutura do COE é de responsabilidade do(a) subsecretário(a) de Vigilância em Saúde, em alinhamento com o(a) Secretário(a) de Estado de Saúde ou de instância por ela designada, com base na análise do cenário epidemiológico, ambiental e assistencial feita pelo CIEVS-MG. Essa decisão deverá considerar critérios técnicos previamente estabelecidos: incluindo a gravidade do evento, a extensão territorial, o número de municípios afetados — conforme dados da CEDEC — e o potencial de impacto sobre o sistema de saúde (Brasil, 2026).

No momento de sua ativação, são adotadas medidas que asseguram a estruturação e o funcionamento do COE. Entre elas, destaca-se a convocação dos líderes dos eixos técnicos do Plano de Contingência,

assim como a avaliação dos atores internos e externos necessários para uma resposta eficaz. Abaixo estão descritas as ações necessárias de acordo com a proposta deste plano:

- Convocar líderes dos eixos técnicos do plano de contingência para composição do COE (avaliar previamente quais atores, tanto internos quanto externos, são necessários para uma resposta eficaz à emergência);
- Designar profissionais para fornecer suporte administrativo e garantir o funcionamento adequado do COE;
- Escolher oficialmente um porta-voz responsável por comunicar informações à mídia e autoridades durante a resposta à emergência;
- Definir os períodos operacionais e convocatória para o briefing e debriefing – estabelecer os horários operacionais e organizar reuniões regulares de briefing e debriefing para avaliação e planejamento das ações do COE (as reuniões podem ser diárias ou até semanais conforme o contexto epidemiológico);
- Elaborar o Plano de Ação do Evento (PAE), que descreva as ações a serem tomadas em resposta ao evento de emergência, embasado neste Plano de Contingência;
- Executar as ações delineadas no PAE para lidar efetivamente com a emergência;

- Elaborar Matriz de responsabilidade a qual define claramente as responsabilidades individuais de cada membro da equipe durante a resposta à emergência;
- Determinar oficialmente as prioridades a serem seguidas durante as operações de resposta à emergência;
- Ativar as operações iniciais e imediatas para responder à emergência;
- Definir o tipo de suporte necessário às operações, incluindo recursos humanos, materiais e insumos, considerando a previsão de evolução dos impactos do evento;
- Elaborar relatórios de acompanhamento do PAE, conforme a realização das ações previstas;
- Elaborar informes para divulgação às autoridades envolvidas e à mídia, mantendo todos os interessados atualizados sobre a situação e as ações do COE.

Diante do acima exposto, serão responsabilidades do COE:

- Monitorar e avaliar todas as ações relacionadas às respostas à emergência;
- Monitorar os indicadores estratégicos;
- Conduzir as reuniões ordinárias e atualizar a matriz de responsabilidades;
- Garantir uma resposta coordenada a emergência com planejamento em parceria com todos os atores envolvidos do estado e municípios;

- Fazer articulação com gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e outros órgãos públicos;
- Propor medidas, como o acionamento de equipes de saúde (tais como equipe de campo e Força estadual) ações assistenciais, distribuição de recursos e campanhas educativas;
- Garantir uma comunicação eficaz a fim de informar a imprensa, profissionais, governo e a população em geral sobre o status da emergência ou do evento e quais ações estão sendo tomadas;
- Elaborar relatórios técnicos para subsidiar a tomada de decisão;
- Redigir ofícios intersetoriais e ofícios externos para comunicação formal com outros órgãos e instituições.

A desativação do COE ocorrerá de forma gradual, a partir da reavaliação sistemática do cenário, considerando a redução sustentada do número de municípios em situação de emergência, a normalização ou estabilização do abastecimento de água, a diminuição dos indicadores de risco à saúde elencados, o restabelecimento da capacidade de resposta dos serviços de saúde e a redução da necessidade de coordenação intersetorial intensiva. A decisão de desinstalação deverá ser formalizada pela autoridade competente, podendo incluir o rebaixamento progressivo do nível de ativação antes do encerramento completo das atividades (Brasil, 2026).

A desinstalação do COE deverá ser formalizada por meio da emissão de ato oficial de desativação, seguida da elaboração de relatório final da operação, contemplando a análise das ações desenvolvidas, os resultados alcançados e as lições aprendidas. Deverá ser realizada a sistematização e o arquivamento das informações produzidas durante o período de ativação, bem como a elaboração de recomendações para o aprimoramento de planos futuros. Por fim, as atividades deverão ser gradualmente reconduzidas às rotinas ordinárias da Secretaria de Estado de Saúde (Brasil, 2026).

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Plano de Enfrentamento aos Impactos do El Niño configura-se como um instrumento estratégico e orientador para a atuação do setor saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais, estabelecendo diretrizes para a organização, a preparação, a resposta e o monitoramento das ações frente aos impactos decorrentes desse fenômeno climático sobre a saúde da população. Sua estrutura foi elaborada para subsidiar a tomada de decisão em diferentes cenários de risco, considerando a diversidade de eventos adversos associados ao El Niño, a evolução de sua intensidade e a necessidade de atuação oportuna, integrada e baseada em evidências.

Ressalta-se que este plano foi construído de forma colaborativa, envolvendo diferentes áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, refletindo o compromisso institucional com a atuação integrada e intersetorial frente aos impactos do fenômeno El Niño. Esse processo coletivo fortalece a governança na gestão do risco de desastres e das emergências em saúde pública relacionadas aos eventos climáticos extremos, evidenciando a capacidade de articulação, planejamento, monitoramento e resposta coordenada da SES-MG para reduzir os impactos sobre a saúde da população.

6.REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). **El Niño 2026/2027 e impactos esperados no Brasil**. Nota Técnica n.º 627/2026/SEI-CEMADEN. São José dos Campos: CEMADEN, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/cemaden/pt-br/assuntos/noticias-cemaden/copy2_of_SEI_MCTII3770843NotaTcnica.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2026.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Plano de preparação e resposta ao período chuvoso – 2024. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Saúde, 2021. Atualização 2024.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Plano de preparação e resposta ao período de Seca e Estiagem – 2024. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Saúde, 2022. Atualização 2024.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Nota técnica: chegada do El Niño e potenciais impactos sobre a saúde, os desastres e a organização da resposta pública no Brasil. Rio de Janeiro: Observatório de Clima e Saúde, Laboratório de Informação em Saúde, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE); INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET); FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS (FUNCEME); CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA (CENSIPAM). Nota técnica: El Niño 2026. São José dos Campos: INPE; Brasília: INMET; Fortaleza: FUNCEME; Brasília: CENSIPAM, abr. 2026.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Saúde. **Protocolo de enfrentamento ao calor extremo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Ed. dos Autores, 2024. ISBN 978-65-01-16338-3. Disponível em: [Prefeitura do Rio – Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo](#). Acesso em: 30 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de Mudanças Climáticas e Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2026]. Disponível em: Guia de Mudanças Climáticas e Saúde. Acesso em: 30 jul. 2026

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Mudanças climáticas para profissionais de saúde: guia de bolso. 2. ed. rev. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: Guia de bolso – Mudanças climáticas para profissionais de saúde (PDF). Acesso em: 30 jul. 2026.

7. ANEXOS

7.1 Fluxo de comunicação

Sistemas de monitoramento utilizados

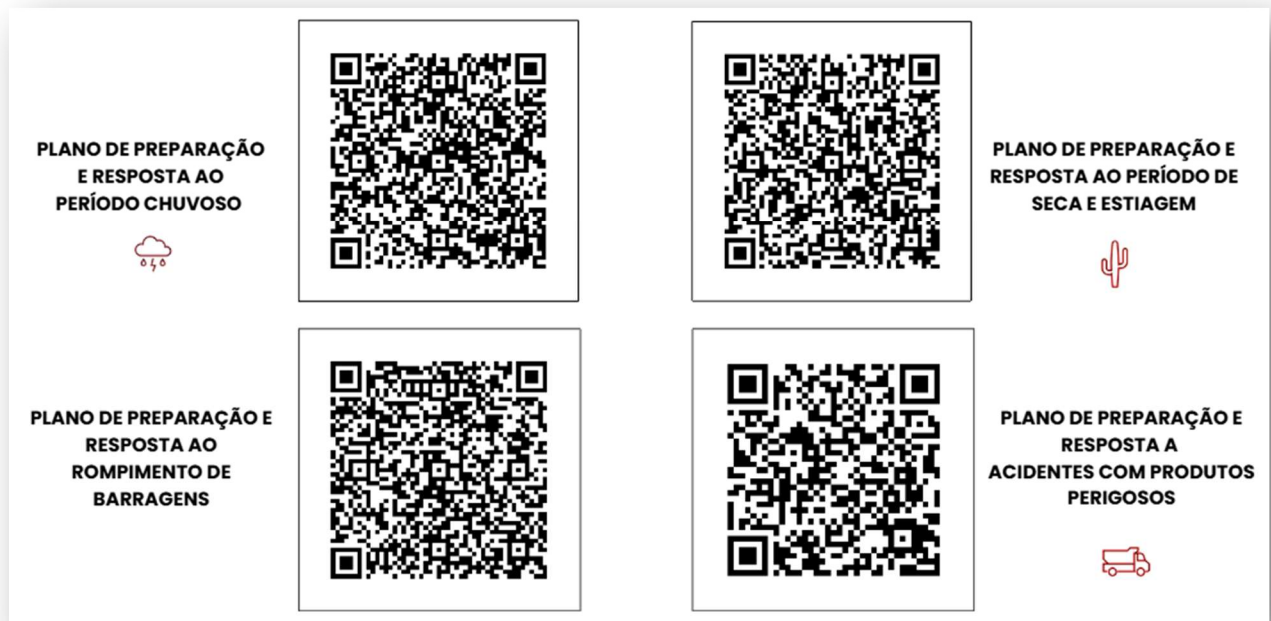
O acompanhamento sistemático de previsões meteorológicas, avisos de tempo severo, alertas hidrológicos, boletins climáticos e demais informações técnicas relacionadas ao fenômeno El Niño permite que os municípios antecipem situações de risco e adotem medidas preventivas frente aos diferentes eventos adversos associados às alterações climáticas provocadas por esse fenômeno. Esses eventos podem incluir chuvas intensas, inundações, enxurradas e deslizamentos, bem como estiagens prolongadas, ondas de calor, queimadas e redução da disponibilidade hídrica. Essa atuação preventiva possibilita maior organização do setor saúde, reduz os impactos sobre a população, fortalece a resposta intersetorial e contribui para minimizar danos humanos, ambientais e socioeconômicos. O monitoramento contínuo constitui um dos pilares da gestão integrada do risco de desastres e da tomada de decisão baseada em evidências.

Na área da Vigilância em Saúde, essas informações subsidiam o planejamento das ações de preparação, mitigação e resposta, permitindo a mobilização antecipada das equipes de saúde, a organização da rede assistencial, o fortalecimento da vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária e a implementação de estratégias de comunicação de risco junto à população. Além disso, o conhecimento prévio sobre a possibilidade de

ocorrência de eventos extremos favorece a adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos agravos à saúde relacionados aos impactos do fenômeno El Niño. Para subsidiar o monitoramento contínuo dos impactos associados ao fenômeno El Niño e apoiar a tomada de decisão pelos gestores e equipes de saúde, recomenda-se a consulta periódica às seguintes plataformas oficiais:

1. Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais
 - [*SIMGE*](#);
2. Instituto Nacional de Meteorologia;
 - [*INMET*](#);
3. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
 - [*CEMADEN*](#);
4. Banco de Dados de Queimadas (BD Queimadas)
 - [*BD QUEIMADAS*](#);
5. Instituto Mineiro de Gestão das Águas
 - [*IGAM*](#);
6. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais
7. *Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais*
 - [*SIMGE*](#);

7.2 Links para painéis e boletins



Fonte: elaboração do autor.

7.3 Adapta-SUS

Desenvolvido a partir de estratégia nacional, o Plano Estadual de Adaptação do Setor Saúde de Minas Gerais (AdaptaSUS-MG) constitui um instrumento estratégico para orientar a atuação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e fortalecer a capacidade adaptativa do Sistema Único de Saúde (SUS) no território mineiro.

Elaborado de forma participativa e intersetorial, o plano está alinhado à Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), ao Plano Clima, ao Programa AdaptaSUS do Ministério da Saúde e aos instrumentos de planejamento e gestão do SUS (Brasil, 2009; Brasil, 2025).

